

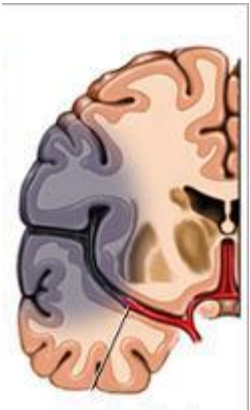


SERVICE DE
NEUROLOGIE
HÔPITAL HABIB BOURGUIBA
Sfax - Tunisie

Sujet n°1

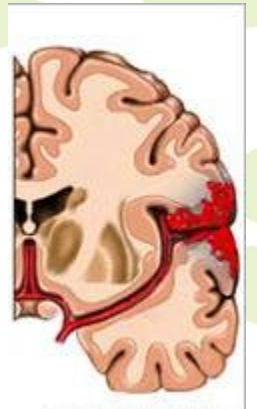


Les Accidents Vasculaires Cérébraux (Évaluation)



Pr. Ag. Khadija Sonda MOALLA

Service de Neurologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax
Faculté de Médecine de Sfax



LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX ISCHÉMIQUES

Objectif 1 :

Décrire la vascularisation artérielle de l'encéphale



1. Concernant le système carotidien, quelles sont les branches terminales de l'artère carotide interne ?

- A. Artère ophtalmique
- B. Artère cérébrale antérieure
- C. Artère cérébrale moyenne
- D. Artère choroïdienne antérieure
- E. Artère communicante antérieure



2. Concernant le système vertébro-basilaire :

- A. L'artère vertébrale droite prend naissance du tronc artériel brachio-céphalique
- B. Les artères cérébelleuses supérieures constituent des branches terminales
- C. L'artère cérébelleuse postéro-inférieure est une branche collatérale de l'artère vertébrale
- D. L'artère communicante postérieure est une branche terminale du tronc basilaire.
- E. Les artères perforantes constituent des branches collatérales

3. Le polygone de Willis est formé par :

- A. Les artères cérébrales et communicantes antérieures en avant
- B. Les 2 artères cérébrales postérieures en arrière
- C. Les 2 artères communicantes postérieures latéralement
- D. Les 2 artères cérébrales moyennes latéralement
- E. L'artère basilaire au centre



4. Le polygone de Willis:

- A. Assure la communication entre les 2 systèmes carotidiens grâce à l'artère communicante antérieure
- B. Assure la communication entre les 2 systèmes carotidiens grâce à l'artère cérébrale antérieure
- C. Assure la communication entre le système carotidien et vertébro-basilaire grâce aux artères communicantes postérieures.
- D. Assure la communication entre le système carotidien et vertébro-basilaire grâce aux artères cérébrales postérieures
- E. Permet de protéger le cerveau en cas d'occlusion artérielle

5. L'artère cérébrale antérieure vascularise:

- A. Le gyrus cingulaire
- B. La face latérale du cerveau
- C. La tête du noyau caudé
- D. Le corps calleux
- E. Le septum pellucidum



6. Concernant le territoire de l'artère cérébrale moyenne, quelles structures sont vascularisées ?

- A. La face latérale du lobe frontal
- B. La face interne du lobe temporal
- C. La capsule externe
- D. L'insula
- E. Le lobe occipital



7. Le territoire profond de l'artère cérébrale moyenne comporte:

- A. La capsule interne
- B. La queue du noyau caudé
- C. Le thalamus
- D. Le noyau lenticulaire
- E. Le plexus choroïde



8. L'artère choroïdienne antérieure vascularise:

- A. L'amygdale temporale
- B. Le bras postérieur de la capsule interne
- C. Le splénium du corps calleux
- D. Le putamen
- E. Le thalamus



9. L'artère cérébrale postérieure vascularise:

- A. L'uncus de l'hippocampe
- B. Le thalamus
- C. Les voies optiques
- D. Le splénium du corps calleux
- E. Le lobe occipital



10. Le territoire profond de l'artère cérébrale postérieure profonde comporte:

- A. L'amygdale temporale
- B. La région sous thalamique
- C. Le bras postérieur de la capsule interne
- D. Le plexus choroïde
- E. Les pédoncules cérébraux



11. L'artère cérébelleuse postéro-inférieure (PICA) vascularise :

- A. La face supérieure des hémisphères cérébelleux
- B. Le plexus choroïde du 4ème ventricule
- C. La partie postéro-inférieure des hémisphères cérébelleux
- D. Le vermis cérébelleux inférieur
- E. La partie antéro-inférieure des hémisphères cérébelleux



12. Quels sont les types de branches qui assurent la vascularisation du tronc cérébral?

- A. Les artères paramédianes
- B. Les artères circonférentielles courtes
- C. Les artères perforantes
- D. Les artères cérébelleuses
- E. Les artères choroïdiennes



LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX ISCHÉMIQUES

Objectif 2 :

**Décrire la somatotopie corticale des aires
corticales primaires motrices et somesthésiques**



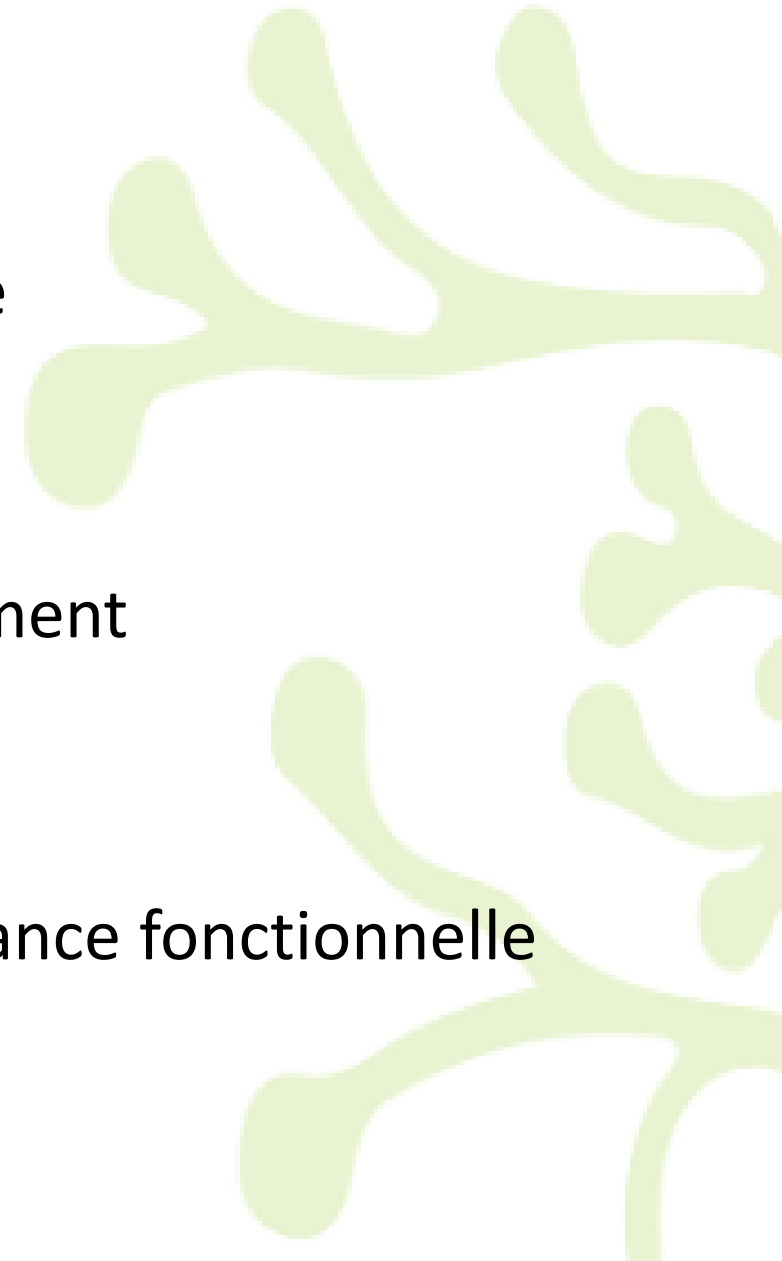
13. L'aire somato-motrice de la motricité volontaire correspond à :

- A. L'aire 4 de Brodmann
- B. Le gyrus pré-central
- C. L'aire 6 de Brodmann
- D. Le gyrus post-central
- E. L'aire 3 de Brodmann



14. Dans l'homunculus moteur :

- A. L'ensemble du corps se projette de façon inversée
- B. Les doigts sont très représentés
- C. Les membres inférieurs sont représentés latéralement
- D. La face est représentée médialement
- E. La surface corticale est proportionnelle à l'importance fonctionnelle



15. L'aire somato-sensitive correspond à :

- A. L'aire 3 de Brodmann
- B. Le gyrus post-central
- C. La circonvolution frontale ascendante
- D. La circonvolution pariétale ascendante
- E. L'aire 4 de Brodmann



16. Les aires cortico-oculo-céphalogyres :

- A. Correspondent à l'aire 8 de Brodmann
- B. Contrôlent les mouvements conjugués des yeux
- C. Contrôlent les mouvements de la tête associés
- D. Se situent dans le lobe pariétal
- E. Correspondent à l'aire de Broca



17. Concernant les aires du langage :

- A. L'aire de Broca est située dans la 5ème circonvolution frontale
- B. L'aire de Wernicke est située dans le lobe temporal
- C. L'aire de Broca est associée à la production des mots
- D. L'aire de Wernicke est associée à la compréhension
- E. Elles sont bilatérales



18. Les aires somato-psychiques associées à l'aire 3 comprennent :

- A. L'aire 1 de perception
- B. L'aire 2 d'interprétation
- C. L'aire 5 somato-gnosique de reconnaissance
- D. L'aire 6 pré-motrice
- E. L'aire 8 oculo-motrice



LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX ISCHÉMIQUES

Objectif 3 :

**Décrire les mécanismes de régulation du débit
sanguin cérébral**



19. La pression de perfusion cérébrale (PPC) est définie par :

- A. $PAM - PIC$
- B. $PAM + PIC$
- C. $PAS - PAD$
- D. $DSC \times \text{résistances vasculaires}$
- E. PAM / PIC



20. Quelle est la valeur normale du débit sanguin cérébral?

- A. 20 ml/min/100g
- B. 30 ml/min/100g
- C. 40 ml/min/100g
- D. 50 ml/min/100g
- E. 60 ml/min/100g



21. Concernant l'autorégulation du débit sanguin cérébral

- A. Le DSC normal est de 50 ml/min/100g
- B. L'autorégulation fonctionne entre 100 et 150 mmHg
- C. Elle maintient un DSC constant malgré les variations de PPC
- D. Elle constitue un mécanisme de protection en cas d'ischémie cérébrale
- E. Elle fait intervenir des modifications du diamètre vasculaire

22. Que se passe-t-il au-delà des seuils d'autorégulation ?

- A. Perte de l'autorégulation
- B. Le DSC suit passivement les variations de PPC
- C. Vasoconstriction systématique
- D. Augmentation de la résistance vasculaire
- E. Risque d'ischémie si PPC < 50 mmHg



LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX ISCHÉMIQUES

Objectif 4 :

**Expliquer la physiopathologie de l'accident
vasculaire cérébral ischémique**



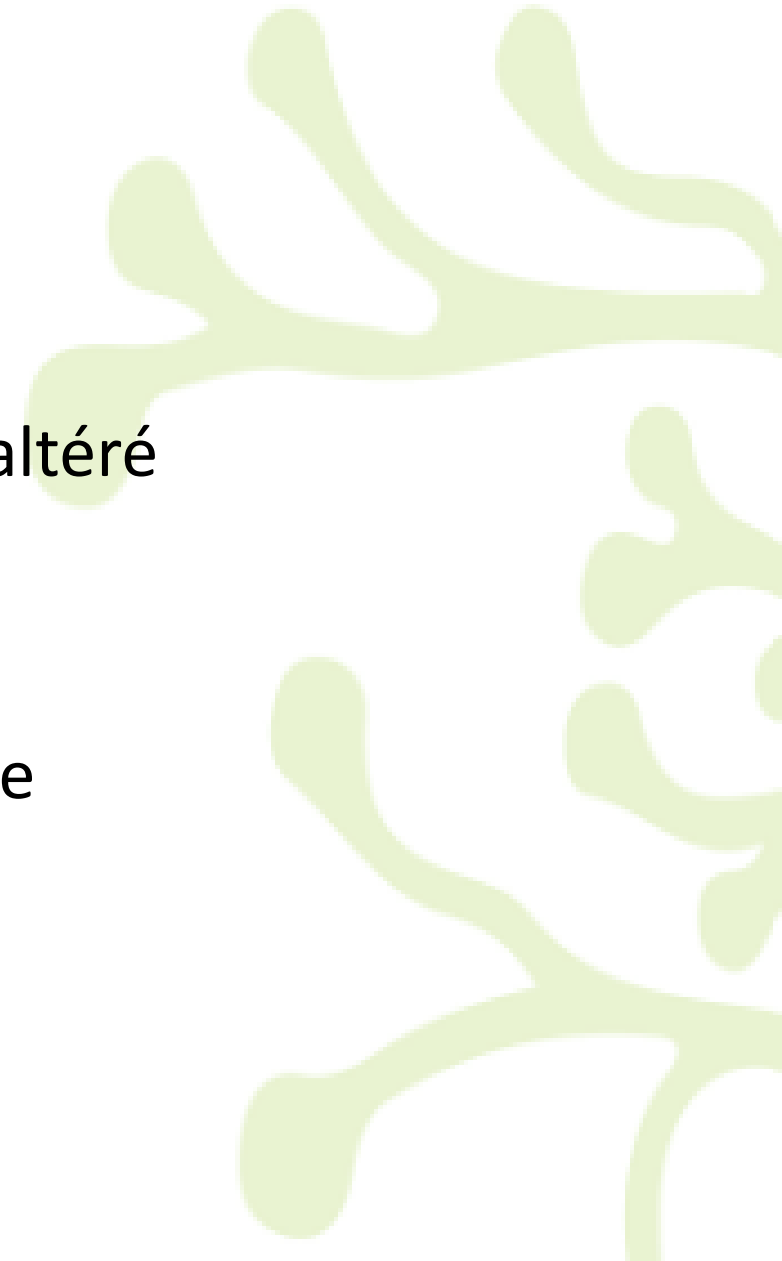
23. Les mécanismes principaux de l'AVC ischémique sont :

- A. Occlusion artérielle par thrombose
- B. Occlusion artérielle par embolie
- C. Spasme artériel primitif
- D. Mécanisme hémodynamique
- E. Rupture artérielle



24. Concernant la pénombre ischémique

- A. Le DSC est inférieur à 10 ml/100g/min
- B. La survie cellulaire assurée mais fonctionnement altéré
- C. Il est responsable des signes déficitaires
- D. La récupération possible si revascularisation rapide
- E. C'est une zone de nécrose irréversible



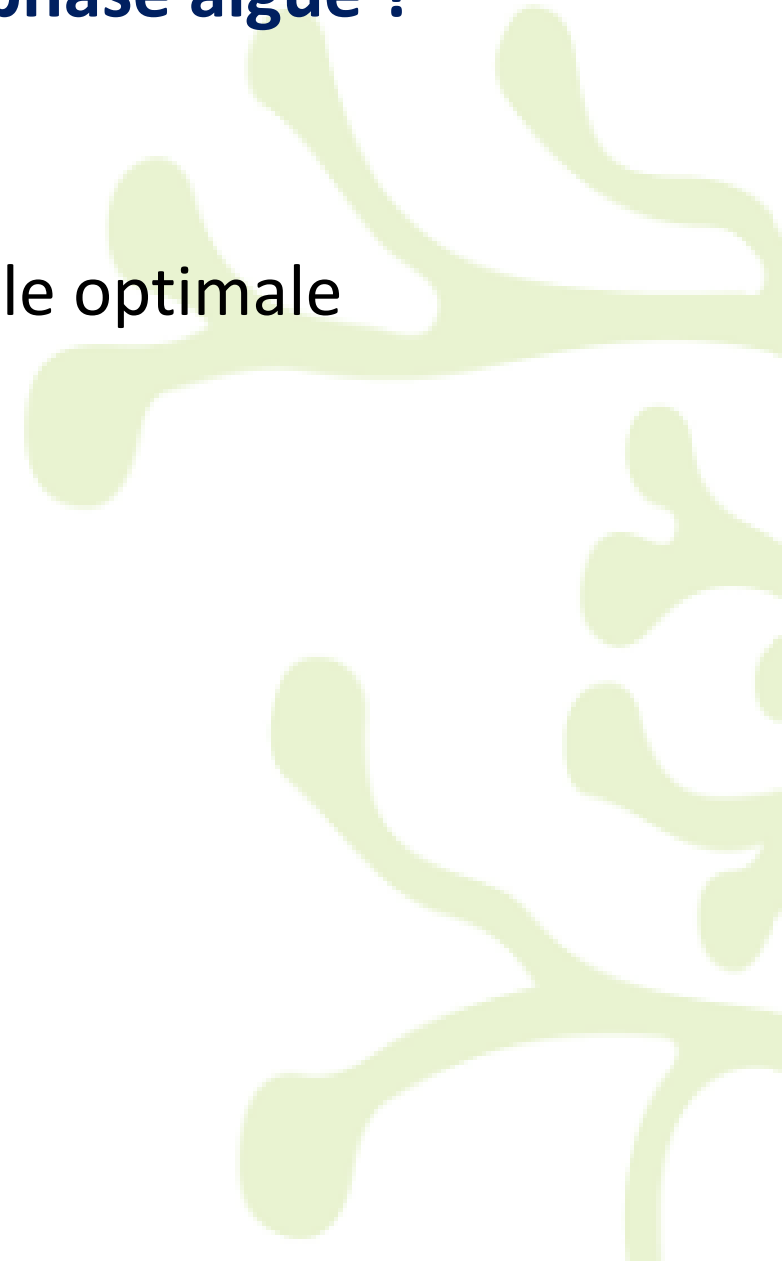
25. L'œdème cérébral post-ischémique est :

- A. Initialement cytotoxique
- B. Initialement vasogénique
- C. Maximal entre le 3ème et 5ème jour
- D. Immédiatement maximal
- E. Régresse spontanément après le 5ème jour



26. Pourquoi faut-il maintenir une PA élevée à la phase aiguë ?

- A. Pour maintenir une pression de perfusion cérébrale optimale
- B. Pour éviter la nécrose de la zone de pénombre
- C. Pour augmenter le débit cardiaque
- D. Pour développer la circulation collatérale
- E. Car l'autorégulation cérébrale est altérée



LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX ISCHÉMIQUES

Objectif 5:

Citer les facteurs de risque d'un AVCI



27. Les facteurs de risque non modifiables de l'accident vasculaire cérébral sont :

- A. L'âge
- B. Le sexe masculin
- C. Les antécédents familiaux
- D. Le tabagisme
- E. L'hypertension artérielle



28. Parmi les facteurs de risque modifiables, lesquels contribuent le plus au risque d'AVC ?

- A. Hypertension artérielle
- B. Fibrillation atriale
- C. Migraine sans aura
- D. Diabète
- E. Le stress chronique

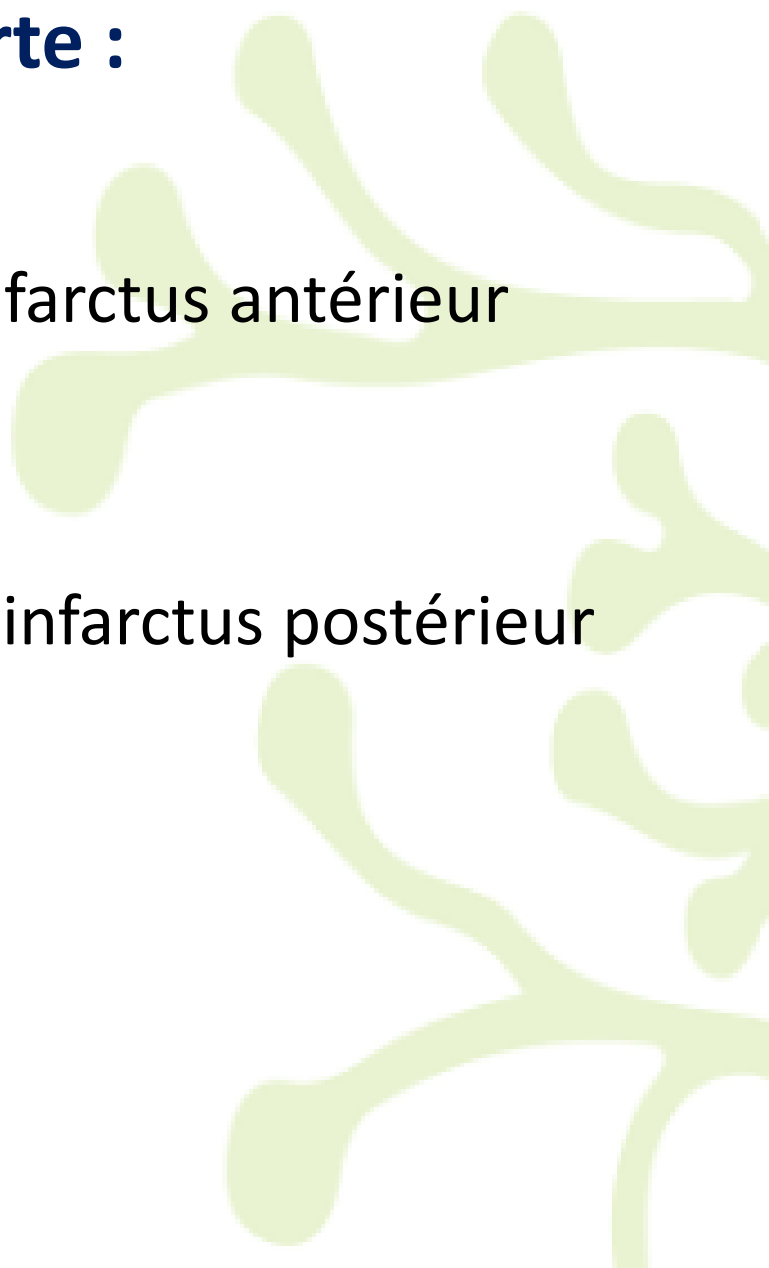


LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX ISCHÉMIQUES

Objectif 6:

**Établir le diagnostic topographique de l'accident
vasculaire cérébral ischémique à partir des données
cliniques et radiologiques**

29. L'atteinte de l'hémisphère majeur comporte :

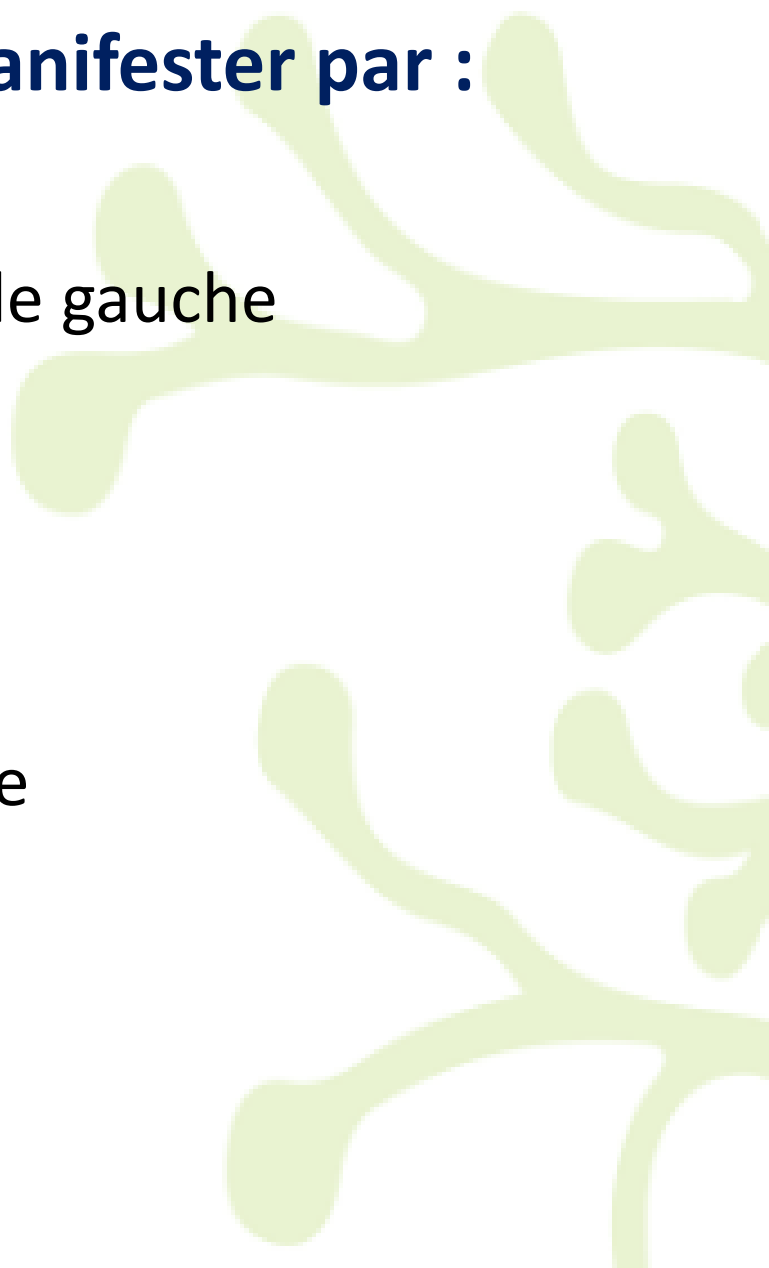
- A. Une aphasie d'expression, non fluente en cas d'infarctus antérieur
 - B. Une anosognosie
 - C. Une aphasie de compréhension, fluente en cas d'infarctus postérieur
 - D. Une héli négligence
 - E. Une apraxie idéomotrice
- 
- A decorative graphic in the bottom right corner consisting of several thick, light green, irregular, branching lines that resemble stylized leaves or a neural network.

30. Le syndrome d'Anton-Babinski comprend :

- A. Une anosognosie
- B. Une aphasie de compréhension
- C. Une héli asomatognosie
- D. Une apraxie idéomotrice
- E. Une héli négligence



31. L'accident vasculaire cérébral ischémique sylvien superficiel gauche chez un droitier peut se manifester par :

- A. Une hémiparésie à prédominance brachio-faciale gauche
 - B. Une hémihypoesthésie droite
 - C. Une hémianopsie latérale homonyme droite
 - D. Une Hémiparésie massive proportionnelle droite
 - E. Une aphasie de Broca
- 

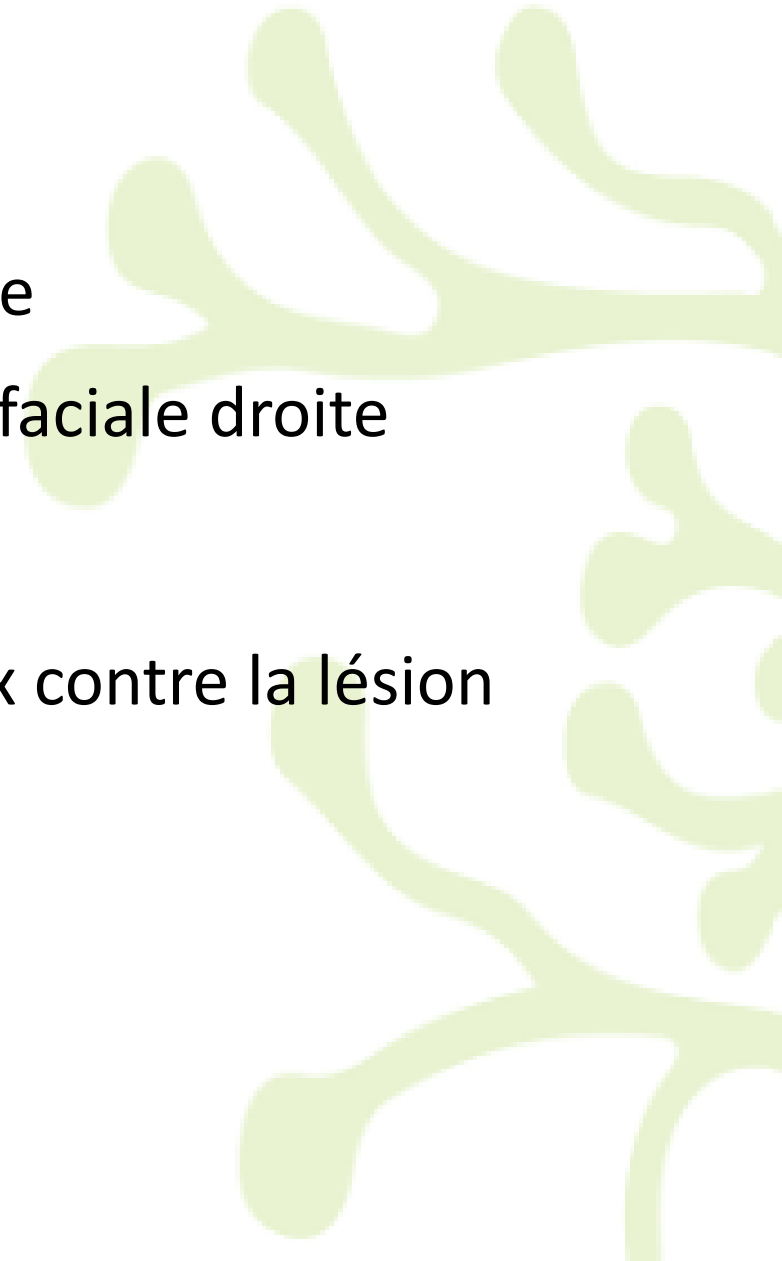
32. L'accident vasculaire cérébral ischémique sylvien profond droit chez un droitier se manifeste par :

- A. Une hémiparésie proportionnelle gauche
- B. Une anesthésie de l'hémicorps gauche
- C. Une cécité corticale
- D. Une paralysie faciale centrale gauche
- E. Une aphasie de wernicke



33. L'accident vasculaire cérébral ischémique sylvien total gauche chez un droitier se manifeste par :

- A. Une hémiparésie massive proportionnelle droite
- B. une hémianesthésie à prédominance brachio-faciale droite
- C. Une hémianopsie latérale homonyme gauche
- D. Une déviation conjuguée de la tête et des yeux contre la lésion
- E. Des troubles de la conscience



34. L'infarctus cérébral dans le territoire de l'artère cérébrale antérieure gauche se manifeste par :

- A. Hémiplégie à prédominance crurale droite
- B. Troubles sensitifs du coté paralysé
- C. Syndrome frontal
- D. Hémiplégie brachio-faciale droite
- E. Hémianopsie droite

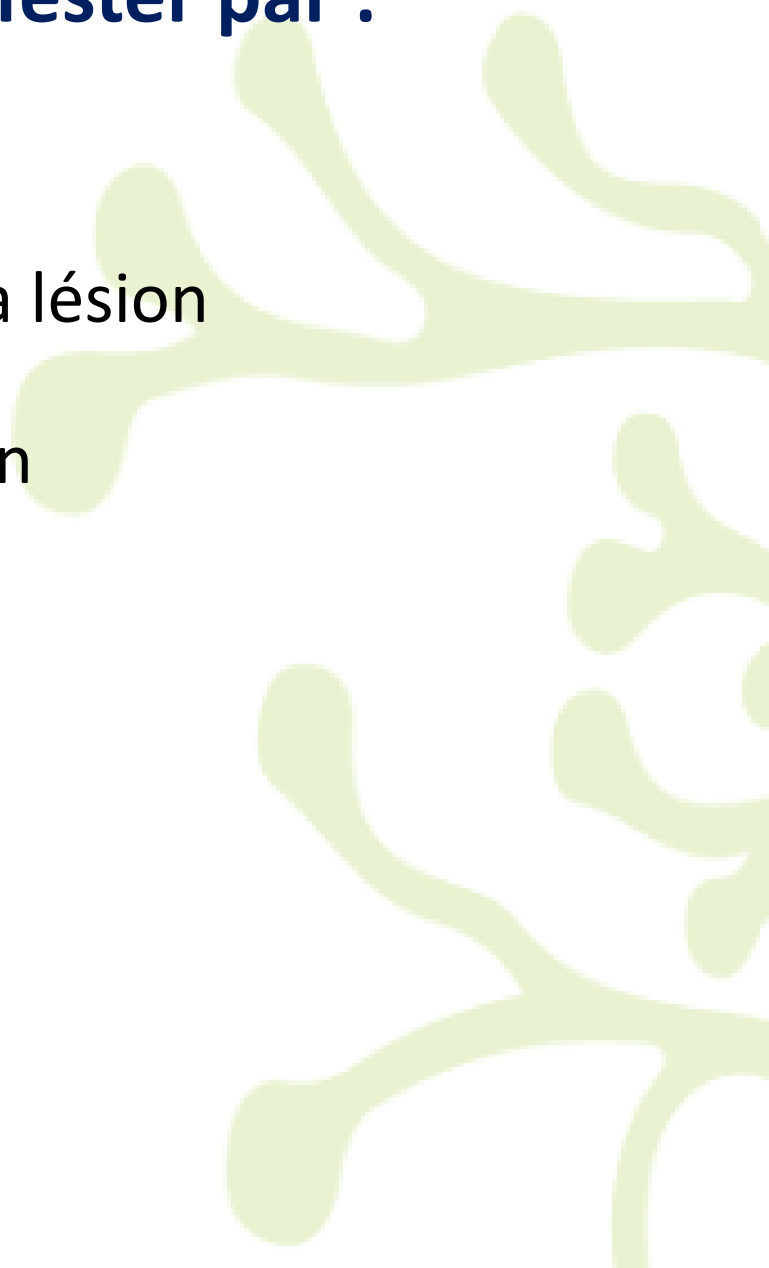


35. Un accident vasculaire cérébral ischémique dans le territoire de l'artère cérébrale postérieure peut se manifester par :

- A. Une prosopagnosie
- B. un syndrome de Korsakoff
- C. un syndrome thalamique
- D. une aphasie de Broca
- E. une hémianopsie latérale homonyme isolée



36. Le syndrome de Wallenberg peut se manifester par :

- A. Syndrome de Claude Bernard-Horner du côté de la lésion
 - B. Hémisyndrome cérébelleux controlatéral à la lésion
 - C. Syndrome vestibulaire controlatéral à la lésion
 - D. Troubles de phonation et déglutition (IX, X)
 - E. Anesthésie de l'hémiface (V) du côté de la lésion
- 

37. Le syndrome de Millard-Gubler peut se manifester par :

- A. une Paralyse faciale centrale du côté de la lésion
- B. une Paralyse faciale périphérique du côté de la lésion
- C. une hémiparésie respectant la face du côté opposé à la lésion
- D. une hémiparésie respectant la face du côté de la lésion
- E. Une déviation du regard vers le côté hémiparétique

38. Le syndrome de Weber associe:

- A. Paralyse complète du III du côté de la lésion
- B. Hémiparésie du côté opposé
- C. Paralyse faciale centrale controlatérale
- D. Syndrome cérébelleux
- E. Troubles sensitifs



39. Le syndrome de Wallenberg est secondaire à une occlusion au niveau:

- A. L'artère cérébelleuse supérieure
- B. L'artère cérébelleuse antéro-inférieure
- C. L'artère cérébelleuse postéro-inférieure
- D. L'artère choroïdienne antérieure
- E. L'artère cérébrale postérieure



40. Concernant le Locked in syndrome :

- A. l'atteinte motrice est bilatérale
- B. Il est secondaire à un infarctus mésencéphalique
- C. Il est secondaire à un infarctus pontique
- D. La conscience est altérée
- E. Les mouvements de verticalité sont conservés



41. un infarctus cérébelleux peut associer:

- A. un héli syndrome cérébelleux cinétique homolatéral à la lésion
- B. des troubles de l'équilibre inauguraux
- C. Des troubles du langage
- D. une hydrocéphalie par compression du V4
- E. Des troubles sensitifs homolatéraux à la lésion



42. Les petits infarctus profonds (lacunes) se caractérisent par:

- A. Taille ≤ 20 mm de grand axe
- B. Occlusion d'une artériole perforante
- C. Lipohyalinose
- D. Localisation corticale
- E. Toujours symptomatiques



43. Les syndromes lacunaires typiques comprennent :

- A. Hémiplégie pure
- B. Hémianesthésie pure
- C. Une Hémianesthésie à prédominance chéiro-orale
- D. Une Dysarthrie paralytique isolée
- E. une aphasie de Broca isolée



LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX ISCHÉMIQUES

Objectif 7:

**Identifier les étiologies de l'accident vasculaire cérébral
ischémique selon l'âge**



44. Concernant les étiologies des infarctus cérébraux:

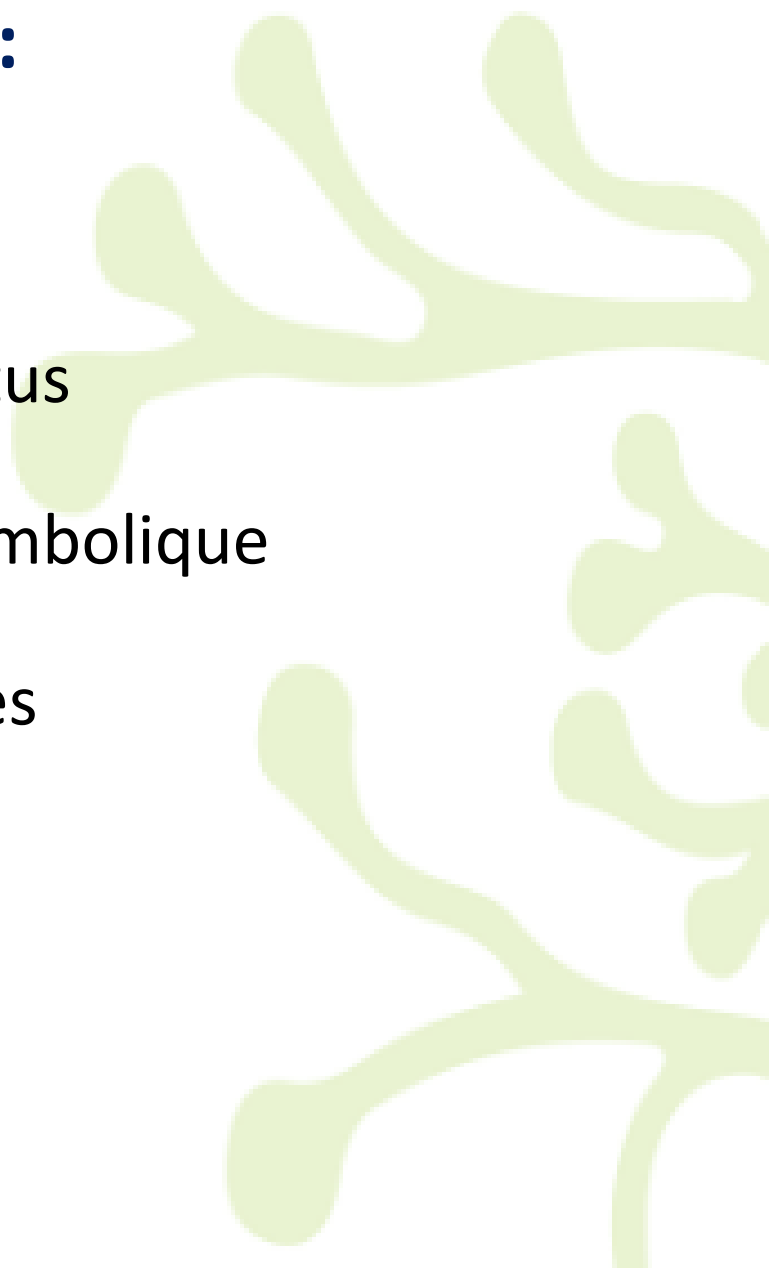
- A. L'hypertension artérielle est l'étiologie la plus fréquente chez le sujet âgé.
- B. La bioprothèse valvulaire constitue une cardiopathie à haut risque emboligène
- C. La dissection des artères cervico-encéphaliques est l'étiologie la plus fréquente des chez le sujet jeune.
- D. La fibrillation atriale est la plus fréquente des cardiopathies emboligènes.
- E. Les infarctus jonctionnels unilatéraux sont évocateurs d'une sténose carotidienne.

45. Quels sont les examens complémentaires à visé étiologique à demander en première intention en cas d'AVCI:

- A. ECG
- B. Angio-IRM cérébrale
- C. Echographie cardiaque
- D. Echographie doppler des TSA
- E. Bilan immunologique

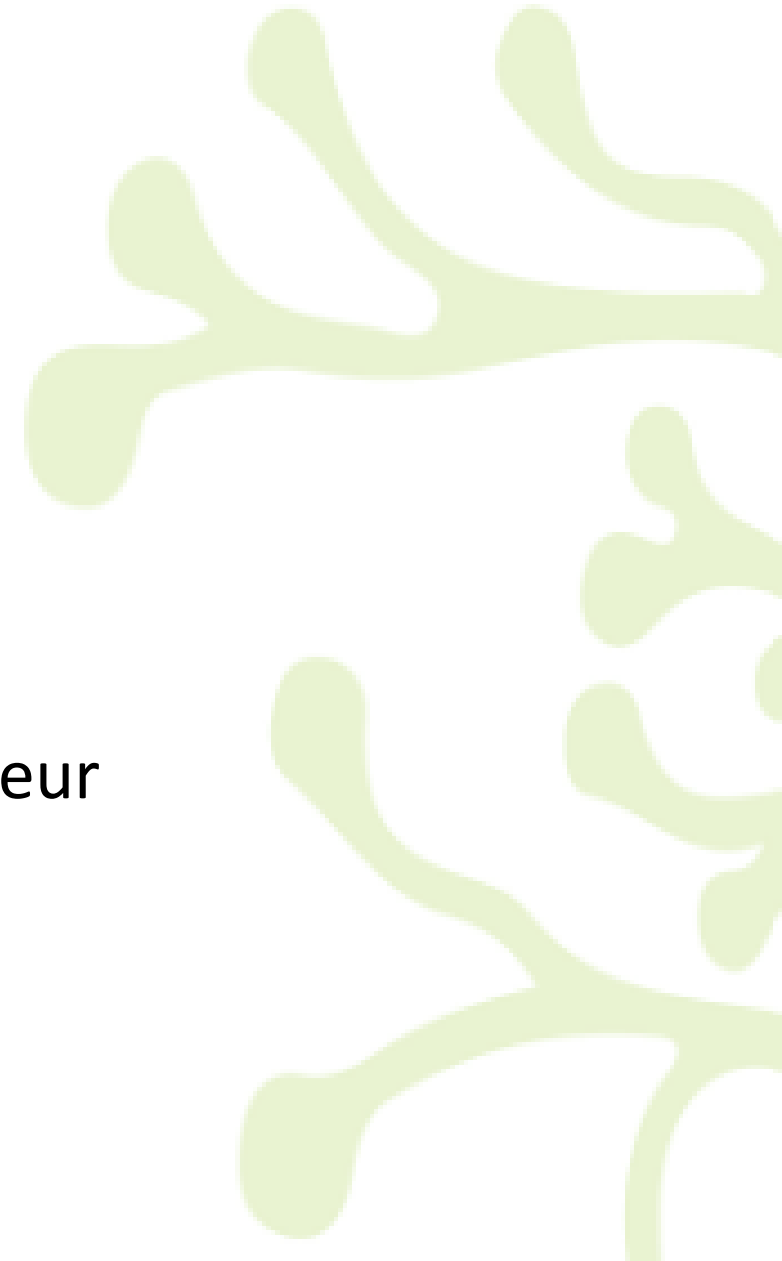


46. L'athérosclérose en tant que cause d'AVCI:

- A. Est l'étiologie la plus fréquente
 - B. Nécessite une sténose > 50% en amont de l'infarctus
 - C. Peut causer un AVCI par un mécanisme thromboembolique
 - D. S'associe souvent aux facteurs de risque vasculaires
 - E. Touche préférentiellement les petites artères
- 

47. Concernant les dissections artérielles :

- A. Cause la plus fréquente d'AVCI chez le sujet jeune
- B. Hématome dans la paroi artérielle
- C. Peut être spontanée
- D. Triade : céphalées + crise épileptique+ déficit moteur
- E. Toujours sur artère pathologique



48. Quels sont les signes qui orientent vers la dissection carotidienne ?

- A. Cervicalgies
- B. Céphalées occipitales
- C. Enophtalmie homolatérale
- D. Acouphènes pulsatiles
- E. Ptosis controlatéral



49. Les cardiopathies emboligènes à risque élevé comprennent :

- A. Fibrillation atriale
- B. Thrombus intracardiaque
- C. Prothèse valvulaire mécanique
- D. Rétrécissement aortique
- E. Prolapsus valvulaire mitral



LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX ISCHÉMIQUES

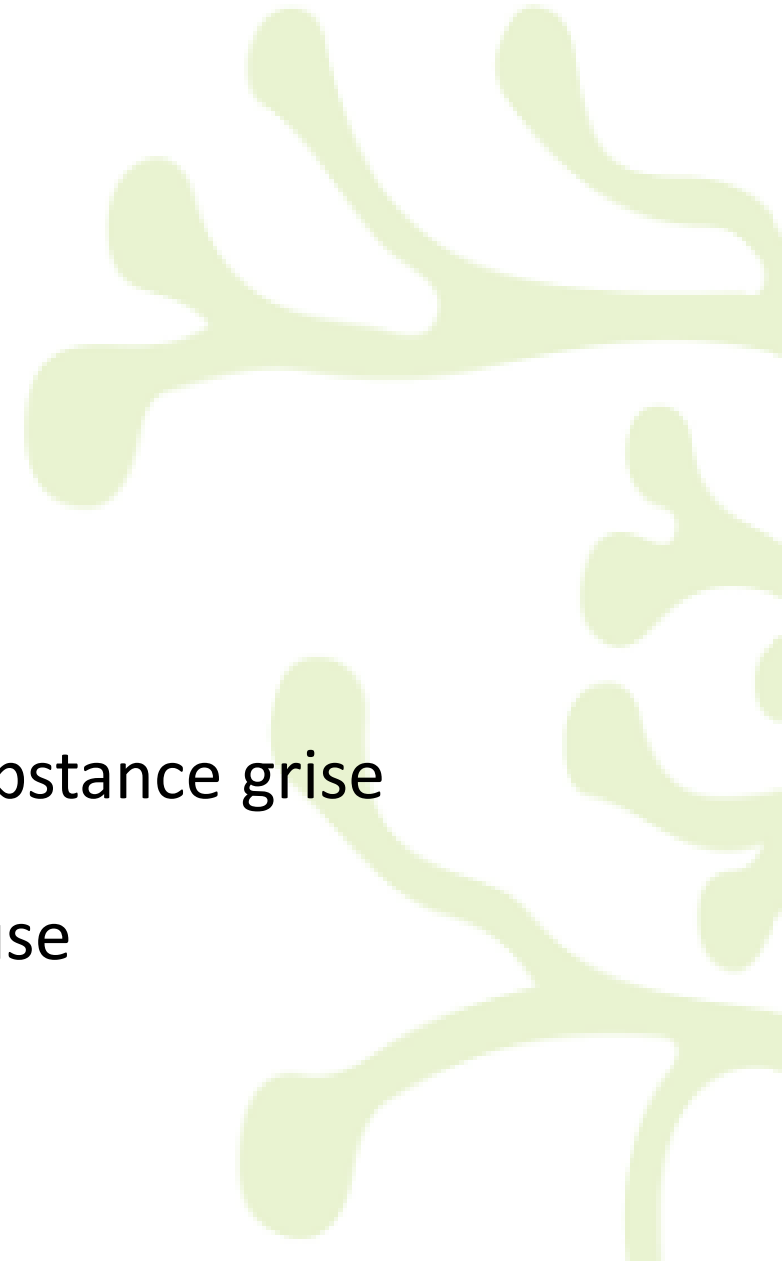
Objectif 8:

**Planifier la prise en charge thérapeutique à la phase
aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique**

50. Les signes précoces d'infarctus cérébral au scanner

cérébral sylvien comprennent :

- A. Trop belle artère sylvienne
- B. Effacement des sillons corticaux
- C. Cavité porencéphalique
- D. Dédifférenciation de la substance blanche/ substance grise
- E. Hyperdensité spontanée intra-parenchymateuse

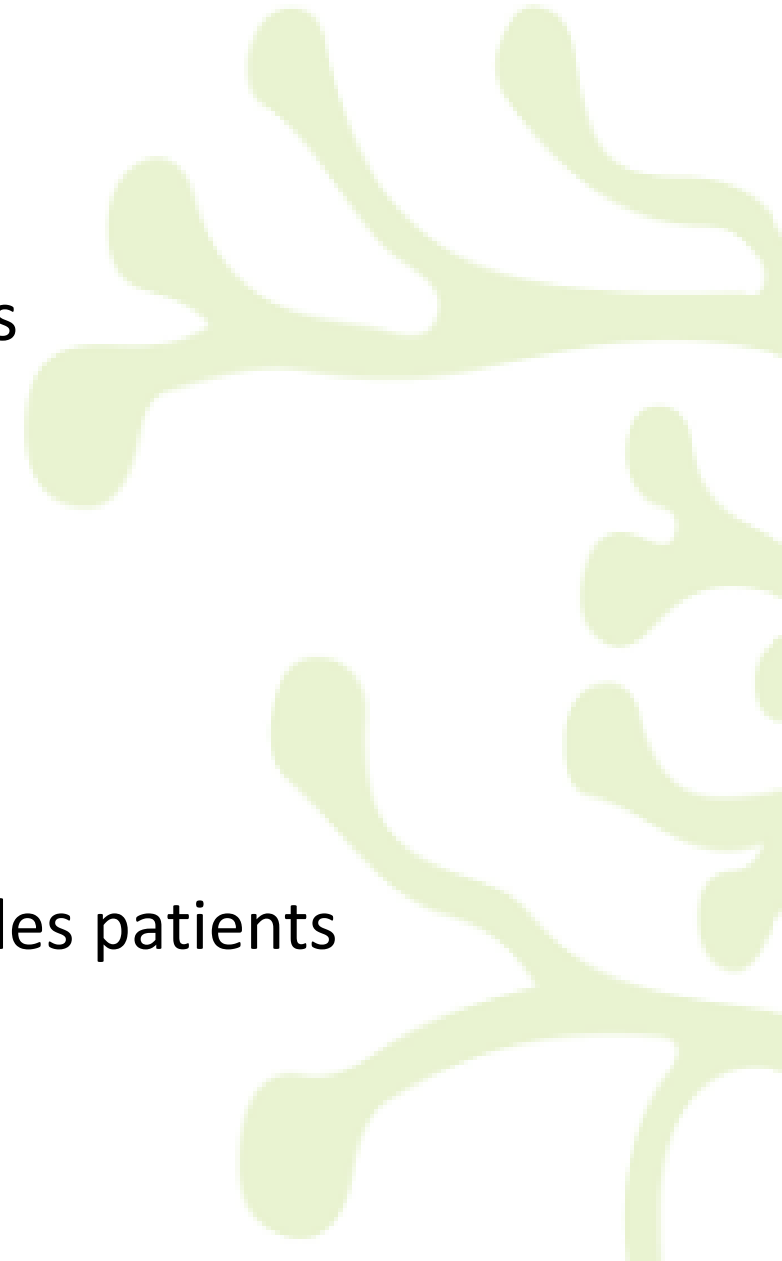


51. La thrombolyse IV des infarctus cérébraux :

- A. Permet de restaurer le débit sanguin cérébral
- B. Empêche la constitution de lésions cérébrales irréversibles
- C. Doit être réalisée avant la sixième heure de l'apparition des symptômes
- D. S'administre à la dose de 0.6mg/kg
- E. Est contre indiquée chez les patients ayant un INR > 1.5

52. Concernant la thrombolyse par rt-PA

- A. indiquée dans les 4h30 suivant les premiers signes
- B. Dose : 0,9 mg/kg
- C. s'administre en bolus unique
- D. le risque d'hémorragie symptomatique est de 6%
- E. elle permet une récupération chez près de 40 % des patients



53. Les contre-indications à la thrombolyse comprennent :

- A. Délai > 4h30 sans mismatch IRM
- B. Hypodensité franche > 1/3 territoire ACM
- C. Un INR < 1,7
- D. TA > 185/110 mmHg malgré traitement
- E. Plaquettes < 150 000/mm³



54. Les mesures générales à la phase aiguë comprennent :

- A. Remplissage par le sérum glucosé
- B. Surveillance de la déglutition
- C. Respect de la poussée tensionnelle
- D. Lutte contre l'hyperthermie
- E. Oxygénothérapie systématique



LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX ISCHÉMIQUES

Objectif 9:

**Planifier la prise en charge au long cours et les
mesures préventives des accidents vasculaires
cérébraux ischémiques**

55. La prévention secondaire de l'athérosclérose comprend:

- A. Antihypertenseurs
- B. Statines
- C. Antidiabétiques
- D. Antiagrégants plaquettaires
- E. Anticoagulants au long cours



56. La chirurgie des sténoses carotidiennes symptomatique

- A. Indiquée pour les sténoses > 70%
- B. L'endartériectomie est la technique de référence
- C. Contre indiquée en cas d'AIT
- D. Contre-indiquée en cas d'infarctus cérébral sévère
- E. Bénéfice augmente avec le délai



57. En cas de fibrillation atriale, la prévention secondaire repose sur :

- A. Les anticoagulants oraux
- B. La double anti agrégation plaquettaire
- C. INR cible entre 2 et 3 pour les AVK
- D. Anticoagulants directs contre-indiqués si ACFA valvulaire
- E. L'aspirine a la même efficacité que les anticoagulants



LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX HÉMORRAGIQUES

Objectif 1:

**Citer les facteurs de risque d'un accident vasculaire
cérébral hémorragique**



58. Les facteurs de risque modifiables de l'AVCH:

- A. L'hypertension artérielle
- B. L'âge
- C. La consommation de cannabis
- D. Le sexe masculin
- E. Le traitement par AVK



LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX HÉMORRAGIQUES

Objectif 2:

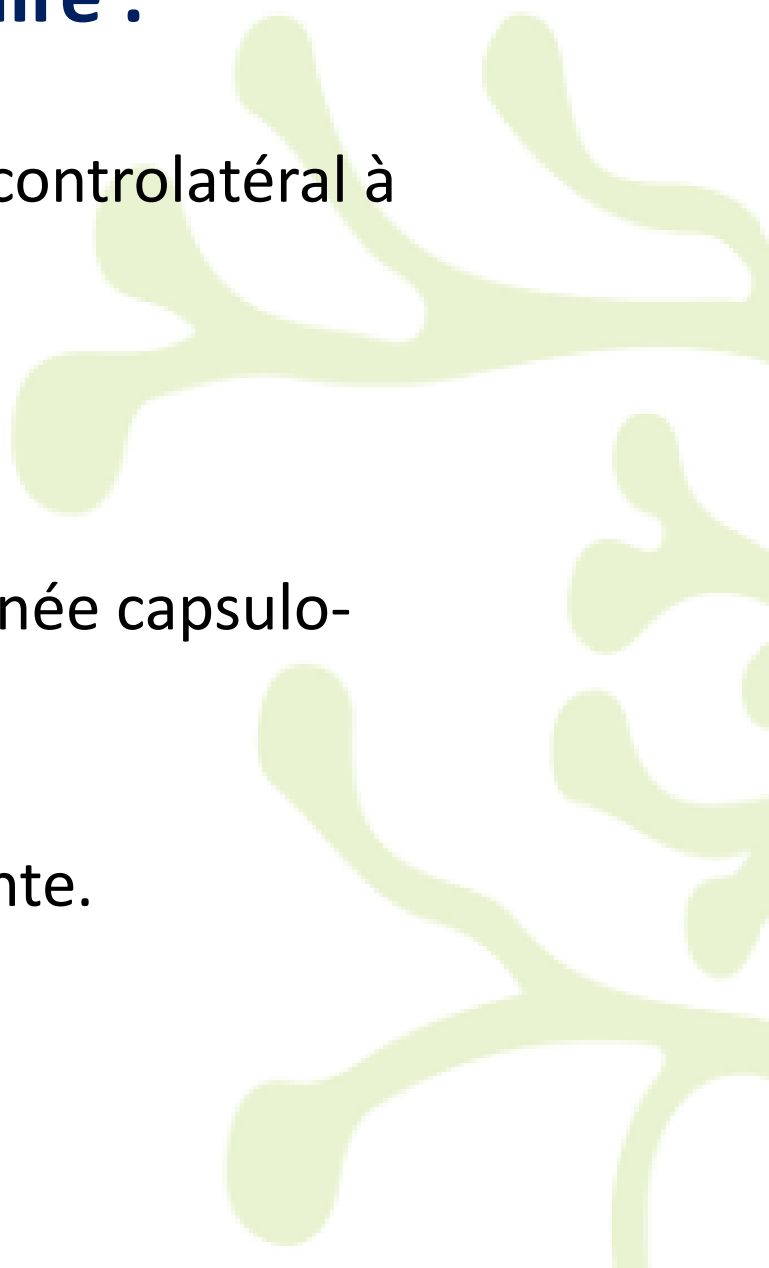
Établir le diagnostic topographique de l'accident vasculaire cérébral

Hémorragique à partir des données cliniques et radiologiques

59. Concernant les hémorragies intra-parenchymateuses:

- A. La symptomatologie clinique répond à une systématisation artérielle
 - B. Les céphalées sont spécifiques
 - C. L'imagerie cérébrale est indispensable
 - D. Les hématomes lobaires sont les plus fréquents
 - E. Les crises épileptiques inaugurales sont évocatrices
- 
- A decorative green abstract graphic consisting of several rounded, branching shapes, resembling stylized leaves or a network, located on the right side of the slide.

60. Concernant l'hématome capsulo-lenticulaire :

- A. Il peut se manifester par un déficit sensitivo-moteur controlatéral à l'hématome.
 - B. Il répond à une systématisation artérielle.
 - C. Le scanner cérébral montre une hyperdensité spontanée capsulo-lenticulaire .
 - D. L'hypertension artérielle est l'étiologie la plus fréquente.
 - E. Sa localisation est lobaire.
- 
- A decorative graphic in the bottom right corner consisting of several light green, rounded, branching shapes that resemble stylized leaves or a network of vessels.

LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX HÉMORRAGIQUES

Objectif 3:

**Identifier les étiologies de l'accident vasculaire cérébral
hémorragique selon l'âge**



61. Le bilan étiologique de l'hématome en fonction de l'âge comporte:

- A. Un bilan de coagulation (plaquettes, TP, TCA)
- B. Une IRM cérébrale
- C. Un Electro-encéphalogramme
- D. Une ETSA
- E. Une angiographie conventionnelle



62. Quelle est l'étiologie la plus fréquente des hémorragies intra-cérébrales:

- A. Rupture d'une malformation vasculaire
- B. HTA chronique
- C. Surdosage en anti-vitamines K
- D. Angiopathie amyloïde
- E. Tumeurs cérébrales



63. L'étiologie la plus fréquente des hémorragies intracérébrales chez le sujet jeune est :

- A. Rupture d'une malformation vasculaire
- B. HTA chronique
- C. Surdosage en anti-vitamines K
- D. Angiopathie amyloïde
- E. Tumeurs cérébrales

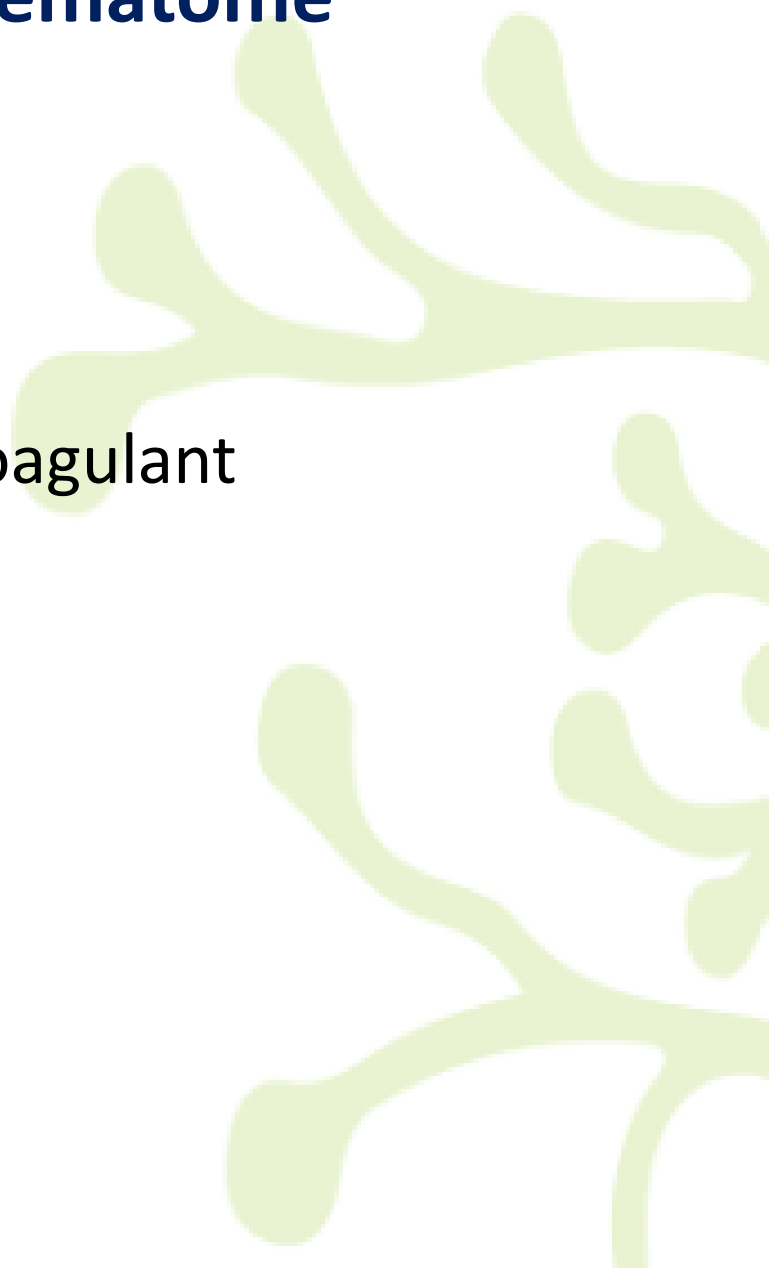


LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX HÉMORRAGIQUES

Objectif 4:

**Planifier la prise en charge thérapeutique à la phase
aiguë de l'accident vasculaire cérébral hémorragique**

64. La prise en charge à la phase aiguë d'un hématome parenchymateux comporte:

- A. Objectif tensionnel < 140/90
 - B. Antagonisation urgente si hémorragie sous anticoagulant
 - C. Surélévation de la tête à 30 degrés
 - D. Thrombolyse si délai < 4h30
 - E. HBPM dose préventive initié le même jour
- 

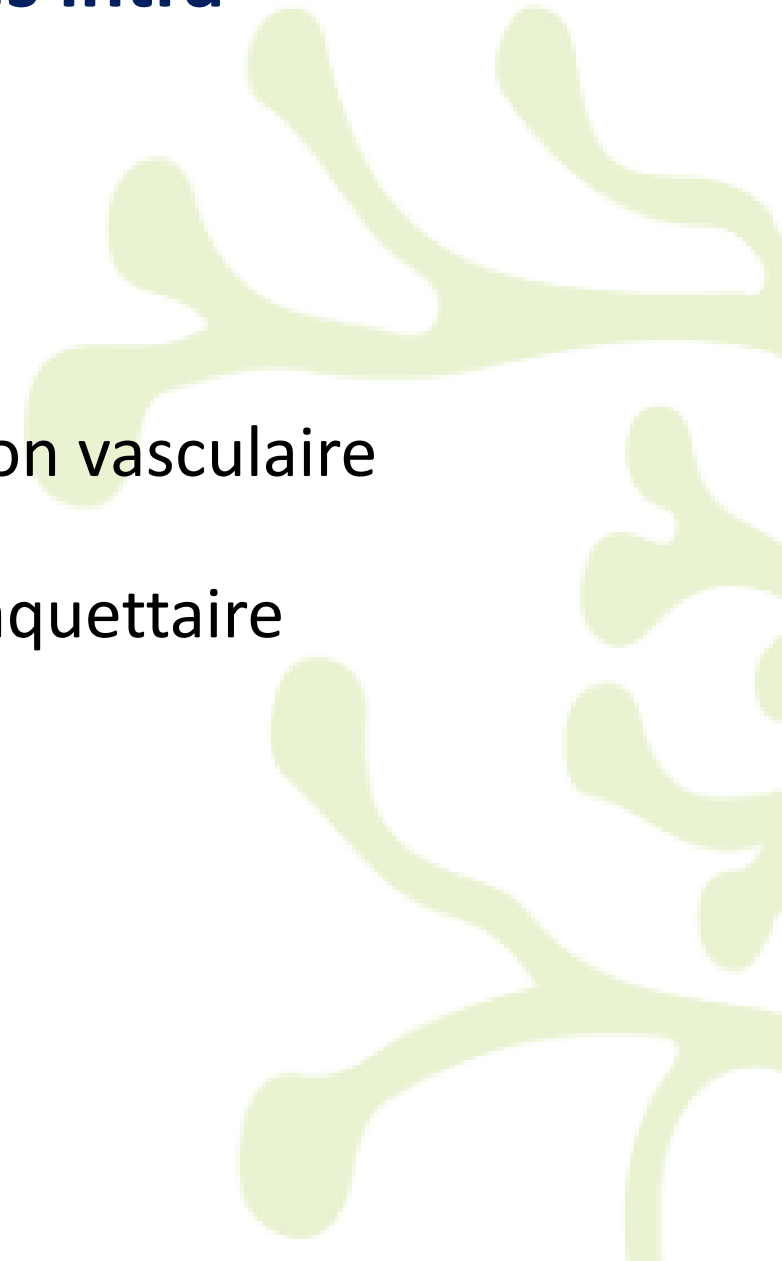
LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX HÉMORRAGIQUES

Objectif 5:

**Planifier la prise en charge au long cours et les mesures préventives
des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques**

65. La prévention secondaire des hémorragies intra parenchymateuses repose sur:

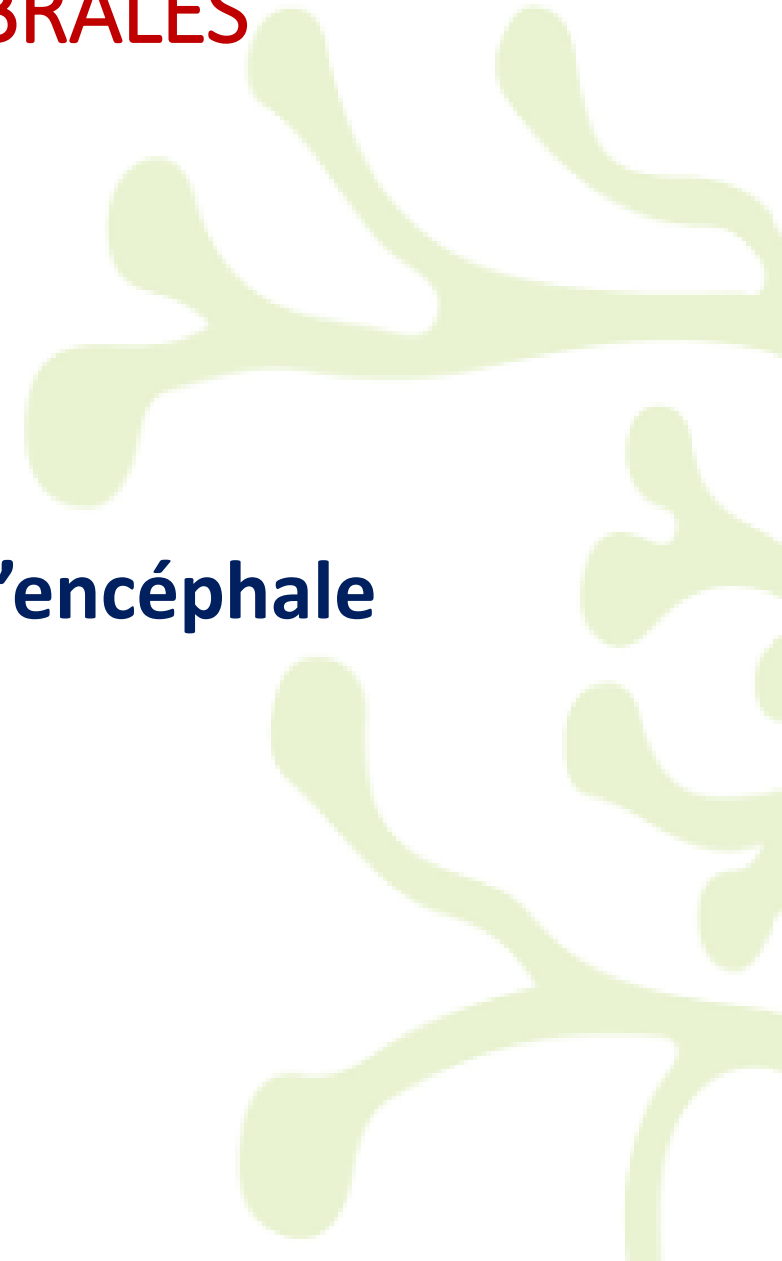
- A. Le traitement de l'HTA
- B. Le traitement endo vasculaire d'une malformation vasculaire
- C. L'administration d'un traitement antiagrégant plaquettaire
- D. La correction d'un trouble de la coagulation
- E. La prescription des statines



LES THROMBOSES VEINEUSES CÉRÉBRALES

Objectif 1:

Décrire la vascularisation veineuse de l'encéphale



66. Les principaux sinus veineux du cerveau sont:

- A. Le sinus sagittal supérieur
- B. Le sinus sagittal inférieur
- C. Le sinus droit
- D. Le sinus caverneux
- E. Le sinus pétreux

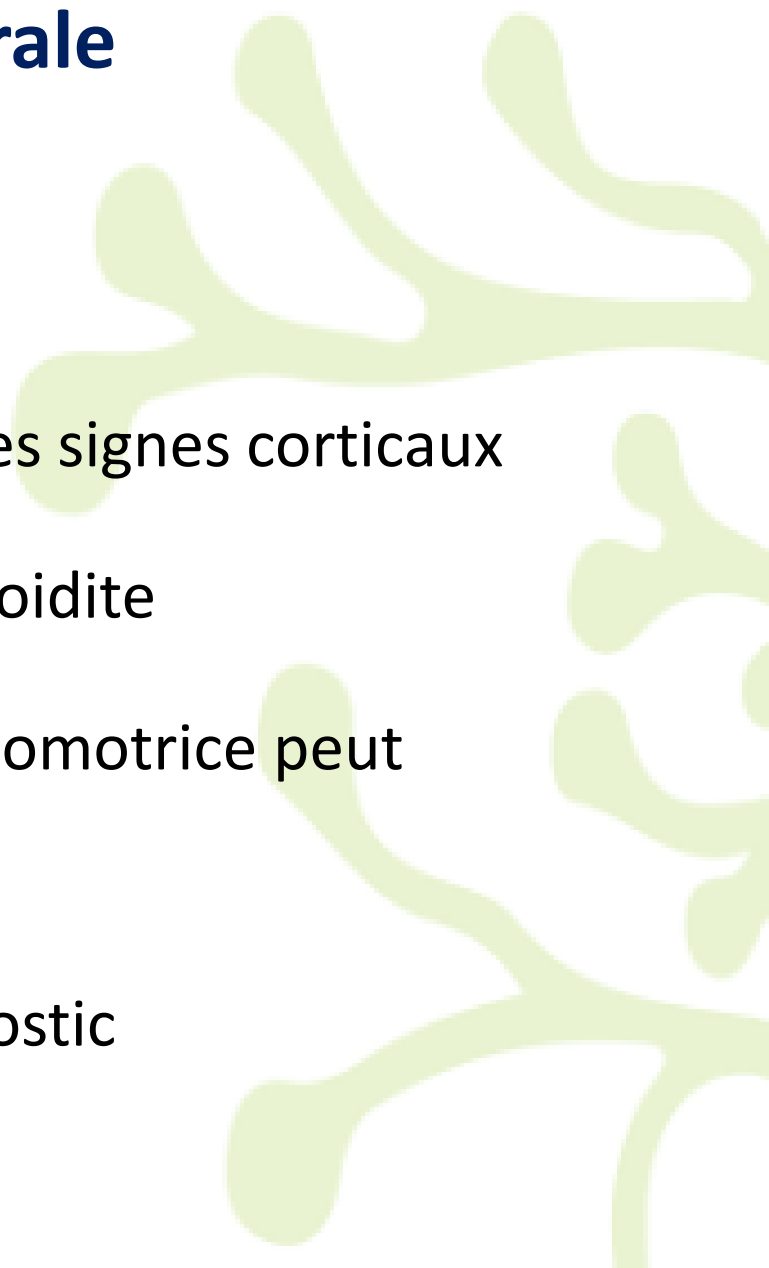


LES THROMBOSES VEINEUSES CÉRÉBRALES

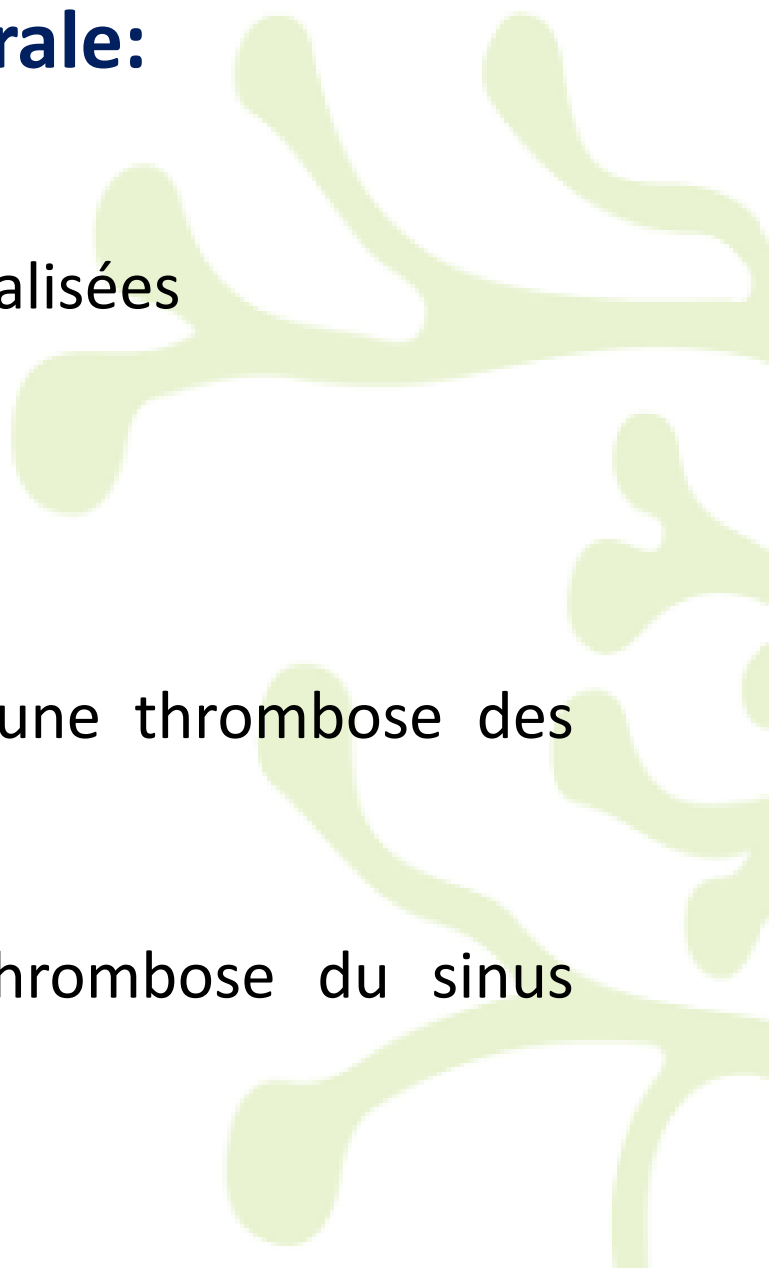
Objectif 2:

**Établir le diagnostic topographique de la thrombose veineuse cérébrale
à partir des données cliniques et radiologiques**

67. Concernant la thrombose veineuse cérébrale

- A. Représente le type le plus fréquent des AVC
 - B. La TVC du sinus sagittal supérieur peut s'associer à des signes corticaux
 - C. La TVC du sinus latéral peut compliquer une otomastoidite
 - D. Au cours de la TVC du sinus caverneux, l'atteinte oculomotrice peut s'observer
 - E. La thrombose des veines profondes est de bon pronostic
- 
- A decorative graphic on the right side of the slide, consisting of several light green, rounded, branching shapes that resemble stylized veins or a network of paths, extending from the top right towards the bottom right.

68. Au cours de la thrombose veineuse cérébrale:

- A. Les crises épileptiques peuvent être focales ou généralisées
 - B. Les crises épileptiques peuvent être inaugurales
 - C. Les céphalées témoignent de l'HTIC
 - D. Des déficits neurologiques à bascule témoignent une thrombose des veines profondes
 - E. Une ophtalmoplégie peut se voir en cas de thrombose du sinus caverneux
- 
- A decorative green abstract graphic consisting of several rounded, branching shapes, resembling stylized veins or a neural network, located on the right side of the slide.

69. La thrombophlébite du sinus caverneux :

- A. Est toujours bilatéral
- B. Se manifeste par une paralysie oculomotrice douloureuse
- C. Se manifeste par une diplopie
- D. Se manifeste par un chémosis
- E. Peut être secondaire à une sinusite



70. La thrombose des veines profondes peut se manifester par:

- A. des troubles de vigilance
- B. une hyper tonie extrapyramidale
- C. des troubles psychiatriques
- D. Une HTIC isolée
- E. Une aphasie

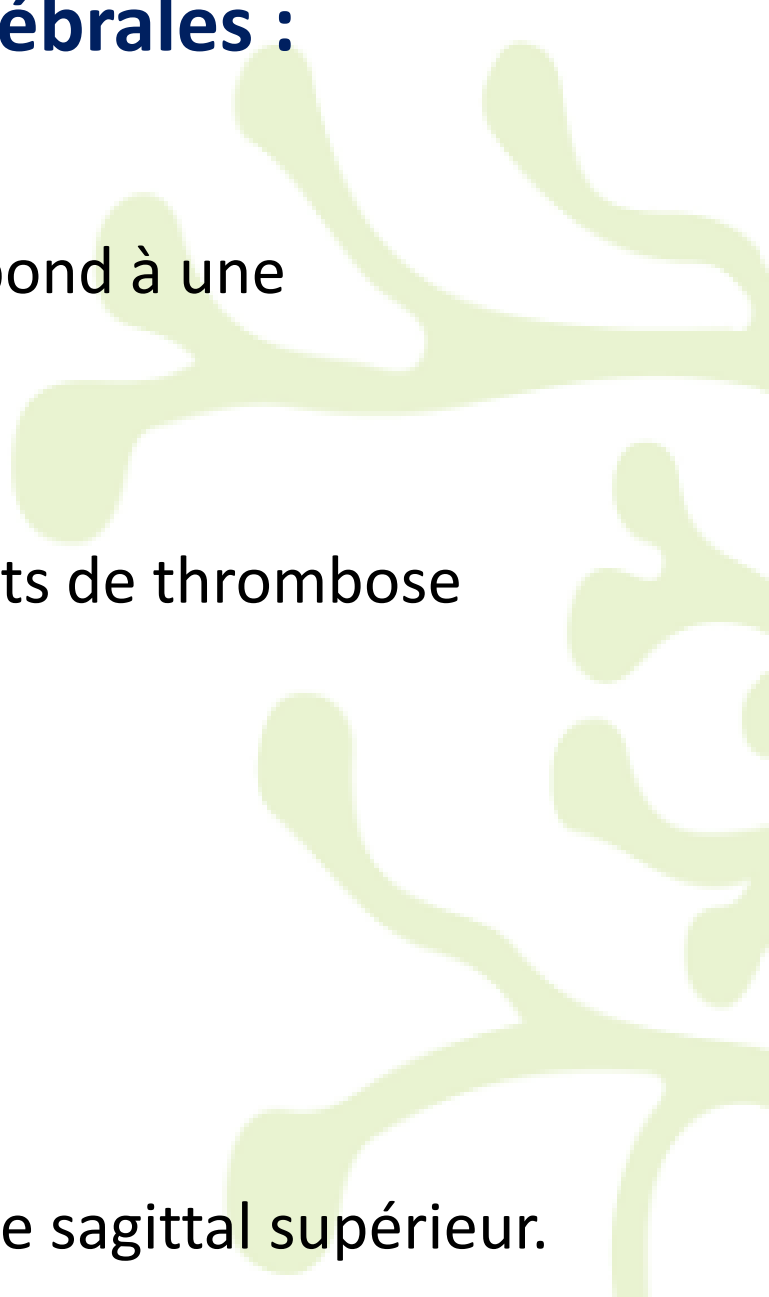


71. Les signes directs d'une thrombose veineuse cérébrale à l'imagerie sont :

- A. Hyperdensité spontanée d'une structure veineuse
- B. Prise de contraste méningée
- C. Infarctus veineux
- D. Signe de Delta vide
- E. Œdème cérébral



72. Concernant les thromboses veineuses cérébrales :

- A. Elles peuvent provoquer un infarctus cérébral qui répond à une systématisation artérielle.
 - B. L'imagerie cérébrale peut montrer des signes indirects de thrombose veineuse cérébrale.
 - C. Les céphalées peuvent être isolées.
 - D. Les déficits neurologiques focaux sont inconstants.
 - E. Une ophtalmoplégie peut se voir en cas de thrombose sagittal supérieur.
- 
- A decorative green abstract graphic consisting of several rounded, branching shapes resembling stylized veins or a neural network, located on the right side of the slide.

Cas cliniques



CAS CLINIQUE 1

Monsieur Ahmed, 65 ans, hypertendu non équilibré, fumeur, consulte aux urgences pour un déficit moteur et sensitif de l'hémicorps droit d'installation brutale survenu il y a 2 heures. L'examen neurologique révèle une hémiplégie droite à prédominance brachio-faciale, une hémianesthésie droite, une hémianopsie latérale homonyme droite et une aphasie d'expression. PA: 175/100 mmHg. Le scanner cérébral fait à H3 était normal. L'écho-doppler des troncs supra-aortiques révèle une sténose carotidienne gauche de 80%.

Question 1

Le territoire artériel le plus probablement atteint est :

- A. Artère cérébrale antérieure gauche superficielle
- B. Artère cérébrale moyenne gauche superficielle
- C. Artère cérébrale moyenne gauche profonde
- D. Artère cérébrale postérieure gauche
- E. Artère choroïdienne antérieure gauche



Question 2

L'aphasie d'expression correspond à une atteinte de :

- A. L'aire de Wernicke
- B. L'aire de Broca
- C. L'aire 4 de Brodmann
- D. L'aire 3 de Brodmann
- E. L'aire 8 de Brodmann



Question 3

La prédominance brachio-faciale de l'hémiplégie s'explique par :

- A. L'atteinte de l'homunculus moteur dans sa partie latérale
- B. L'atteinte de l'homunculus moteur dans sa partie médiale
- C. L'atteinte du territoire profond de l'ACM
- D. L'atteinte du gyrus post-central
- E. L'atteinte de l'aire oculocéphalogyre



Question 4

Concernant la prise en charge thérapeutique immédiate :

- A. Double anti-agrégation plaquettaire
- B. Antiagrégant plaquettaire en monothérapie
- C. Thrombolyse possible si pas de contre-indications
- D. Anticoagulation curative immédiate
- E. Abaissement tensionnel urgent



Question 5

L'étiologie la plus probable de cet AVC est :

- A. Cardiopathie emboligène
- B. Dissection carotidienne
- C. Infarctus lacunaire
- D. Angéite cérébrale
- E. Athérosclérose carotidienne



Cas clinique 2

Madame Fatma, 58 ans, diabétique, se présente aux urgences pour des vertiges intenses, des vomissements et des troubles de l'équilibre d'installation brutale depuis 6 heures. L'examen neurologique révèle : du côté droit (côté de la lésion) : syndrome de Claude Bernard-Horner, ataxie cérébelleuse, troubles de la déglutition, enrouement de la voix, anesthésie de l'hémiface ; du côté gauche : anesthésie thermoalgique de l'hémicorps épargnant la face. L'IRM cérébrale confirme un infarctus latéral du bulbe droit.

Question 1

Ce tableau clinique correspond au syndrome de :

- A. Weber
- B. Millard-Gubler
- C. Wallenberg
- D. Claude
- E. Parinaud



Question 2

L'artère responsable de ce syndrome est :

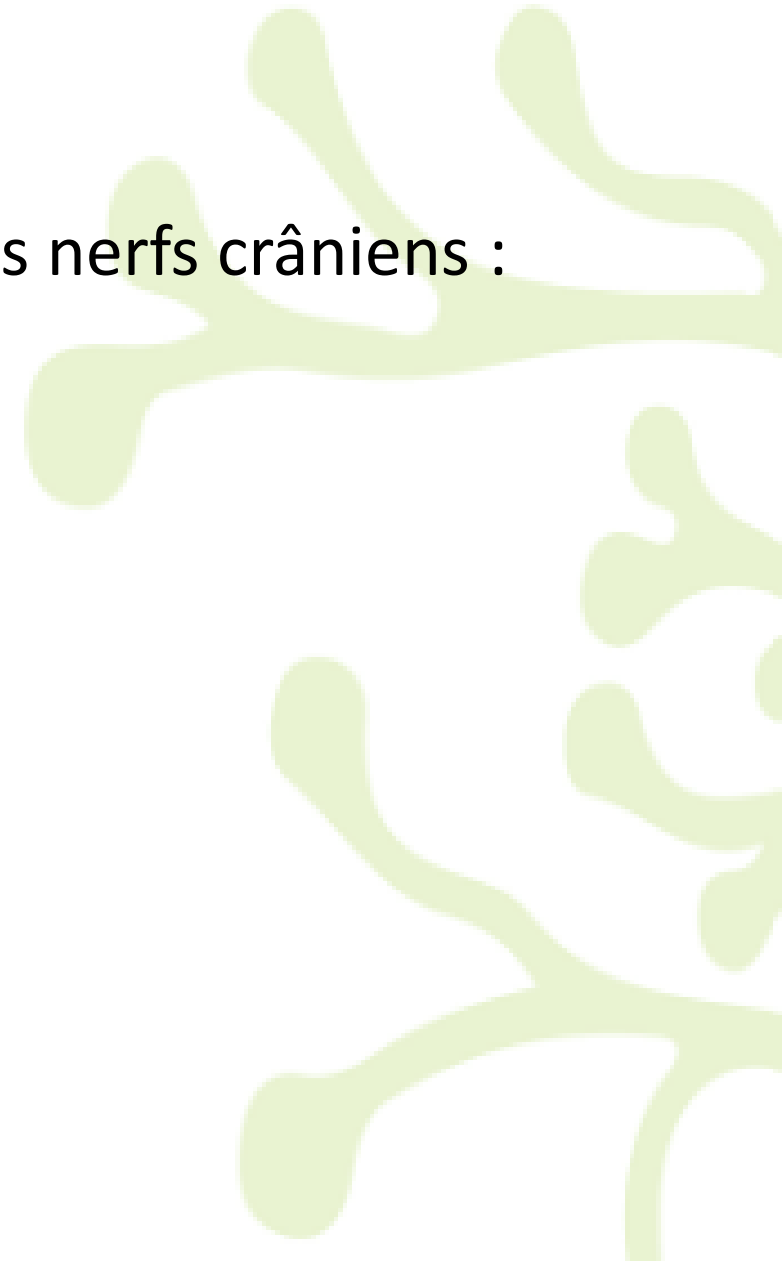
- A. L'artère cérébelleuse supérieure
- B. L'artère cérébelleuse antéro-inférieure (AICA)
- C. L'artère cérébelleuse postéro-inférieure (PICA)
- D. Les artères paramédianes du bulbe
- E. L'artère basilaire



Question 3

Les troubles de la déglutition sont dus à l'atteinte des nerfs crâniens :

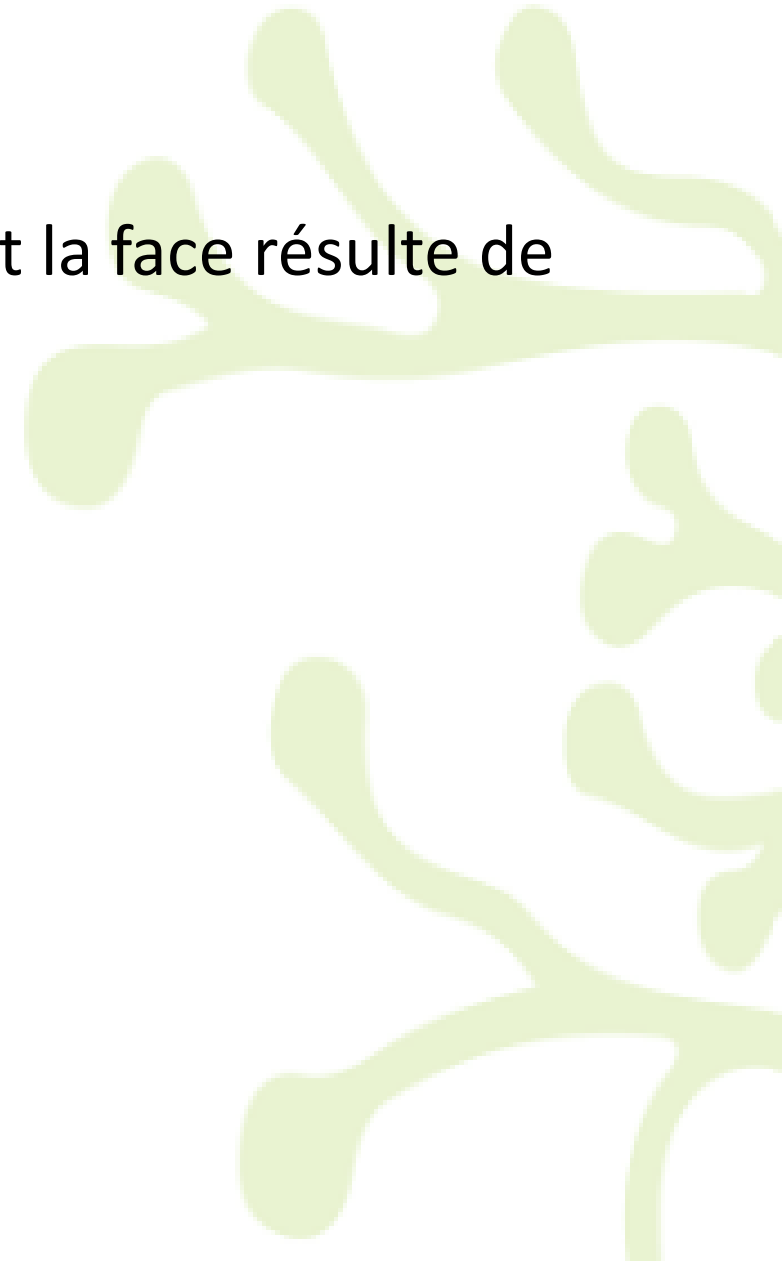
- A. VII et VIII
- B. IX et X
- C. XI et XII
- D. V et VII
- E. III et IV



Question 4

L'anesthésie thermoalgique controlatérale épargnant la face résulte de l'atteinte :

- A. Du faisceau pyramidal
- B. Du lemnisque médial
- C. Du faisceau spinothalamique
- D. Du pédoncule cérébelleux inférieur
- E. De la voie sympathique



Question 5

Une mesure thérapeutique urgente à prendre est :

- A. Thrombolyse immédiate
- B. Mise en place d'une SNG
- C. Anticoagulation curative
- D. Corticothérapie
- E. Chirurgie de décompression



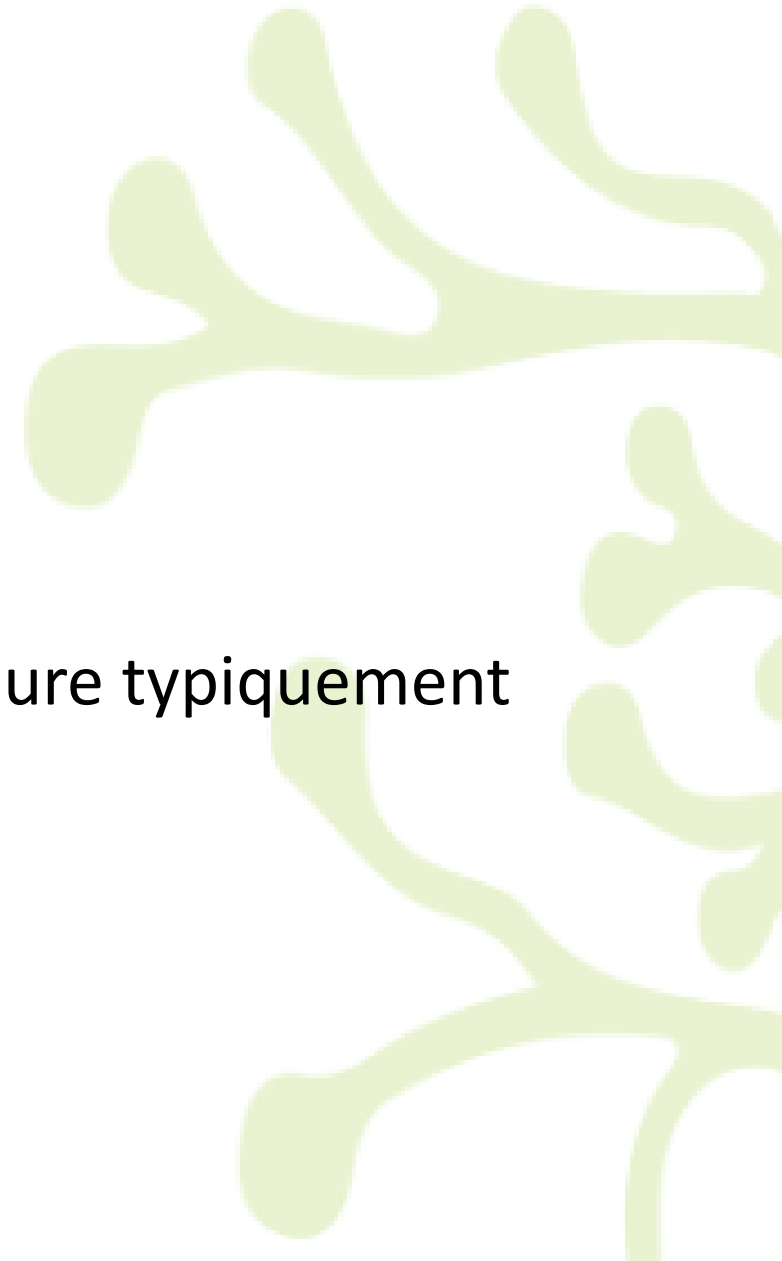
Cas clinique 3

- Monsieur Karim, 45 ans, sans antécédents particuliers, consulte pour un épisode de faiblesse de la main droite et de trouble de la parole ayant duré 20 minutes, survenu ce matin et complètement résolutif à l'arrivée aux urgences. L'examen neurologique est normal. L'ECG révèle une fibrillation atriale. L'IRM cérébrale ne montre pas de lésion ischémique récente. Le diagnostic d'un ALT a été retenu.

Question 1

Concernant la définition de l'AIT :

- A. Déficit neurologique durant plus de 24 heures
- B. Déficit neurologique d'origine artérielle
- C. Déficit neurologique d'origine veineuse
- D. Déficit neurologique réversible en moins d'une heure typiquement
- E. Déficit neurologique avec lésion visible à l'IRM



Question 2

Le principal risque évolutif de cet AIT est :

- A. L'infarctus cérébral constitué dans le mois
- B. La thrombose veineuse cérébrale
- C. L'hémorragie cérébrale
- D. L'épilepsie secondaire
- E. La démence vasculaire



Question 3

L'étiologie la plus probable est :

- A. Athérosclérose carotidienne
- B. Dissection artérielle
- C. Cardiopathie emboligène
- D. Infarctus lacunaire
- E. Angéite cérébrale



Question 4

La prise en charge thérapeutique comprend :

- A. Surveillance simple
- B. Antiagrégant plaquettaire au long cours
- C. Anticoagulation orale
- D. Thrombolyse différée
- E. Aucun traitement car épisode résolutif



Cas clinique 4

- Monsieur Ali, 70 ans, hypertendu depuis 20 ans mal équilibré, diabétique de type 2, consulte pour une faiblesse de l'hémicorps droit d'installation brutale, sans trouble du langage, ni trouble visuel, ni trouble de la conscience. L'examen révèle une hémiparésie droite massive et proportionnelle sans déficit sensitif ni signe cortical. L'IRM cérébrale montre un petit infarctus de 15 mm dans la capsule interne gauche, avec des lésions de leucoencéphalopathie.

Question 1

Ce tableau clinique correspond à :

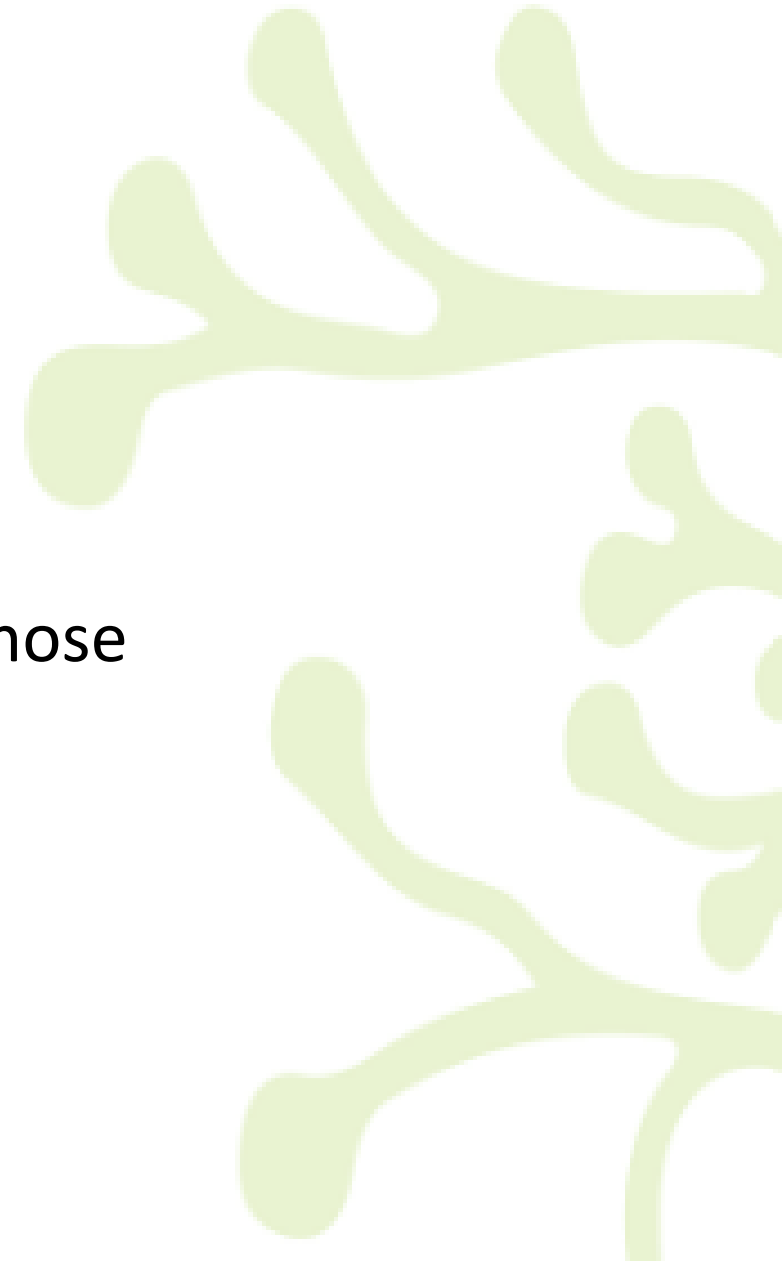
- A. Un infarctus sylvien superficiel
- B. Un infarctus sylvien total
- C. Un syndrome lacunaire
- D. Un infarctus de l'artère cérébrale antérieure
- E. Un infarctus de l'artère cérébrale postérieure



Question 2

Le mécanisme physiopathologique est :

- A. Embolie d'origine cardiaque
- B. Thrombose sur plaque d'athérome
- C. Dissection artérielle
- D. Occlusion d'une artériole perforante par lipohyalinose
- E. Mécanisme hémodynamique



Question 3

Les facteurs de risque principaux de ce type d'infarctus sont :

- A. Fibrillation atriale
- B. Hypertension artérielle
- C. Diabète
- D. Antécédents de Migraine
- E. Antécédents familiaux d'IDM



Question 4

La prévention secondaire repose sur :

- A. Anticoagulation orale au long cours
- B. Contrôle strict des FDR vasculaires
- C. Chirurgie carotidienne
- D. Antiagrégant en monothérapie
- E. Corticothérapie



Cas clinique 5

- Madame Leila, 28 ans, tabagique, sous contraception orale, consulte pour des céphalées intenses diffuses évoluant depuis 5 jours, associées à des vomissements et une crise d'épilepsie généralisée ce matin. L'examen révèle un œdème papillaire bilatéral et une hémiparésie gauche. L'IRM cérébrale montre un infarctus hémorragique pariétal droit et l'angio-IRM révèle une absence de flux au niveau du sinus sagittal supérieur.

Question 1

Le diagnostic le plus probable est :

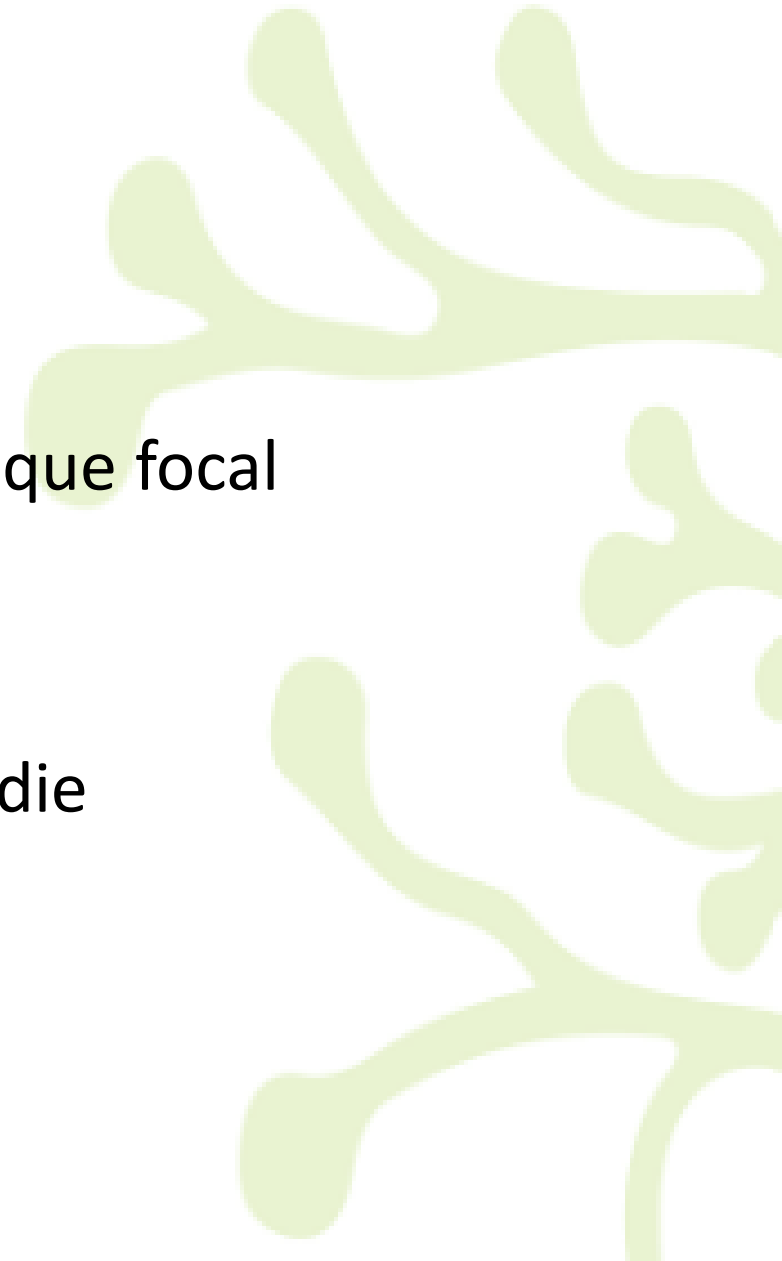
- A. Méningite bactérienne
- B. Hémorragie intraparenchymateuse
- C. Thrombose veineuse cérébrale
- D. Tumeur cérébrale
- E. Encéphalite virale



Question 2

La triade clinique évocatrice comprend :

- A. Céphalées + fièvre + raideur méningée
- B. Céphalées + crises épileptiques + déficit neurologique focal
- C. Hémiplégie + aphasie + hémianopsie
- D. Vertiges + vomissements + ataxie
- E. Troubles de conscience + hypertension + bradycardie



Question 3

L'infarctus associé se caractérise par :

- A. Une topographie systématisée
- B. Une localisation toujours corticale
- C. Une topographie non systématisée
- D. L'absence d'œdème
- E. L'absence de signes d'hypertension intracrânienne



Cas clinique 6

- M. Taieb, 72 ans, hypertendu mal équilibré depuis 15 ans, sous AVK pour fibrillation atriale (INR à 3,2 il y a 3 jours), se présente aux urgences pour des céphalées brutales intenses associées à des vomissements et une hémiparésie droite depuis 2 heures. L'examen révèle une tension artérielle à 200/110 mmHg, un score de Glasgow à 13 et une hémiplégie droite. Le scanner cérébral sans injection montre une hyperdensité spontanée profonde capsulo-lenticulaire gauche. Le bilan biologique confirme un INR à 6.

Question 1

Le diagnostic est :

- A. Infarctus cérébral sylvien profond
- B. Hémorragie intraparenchymateuse profonde
- C. Hémorragie méningée
- D. Thrombose veineuse cérébrale
- E. Tumeur cérébrale hémorragique



Question 2

Ce diagnostic est causé chez ce patient par:

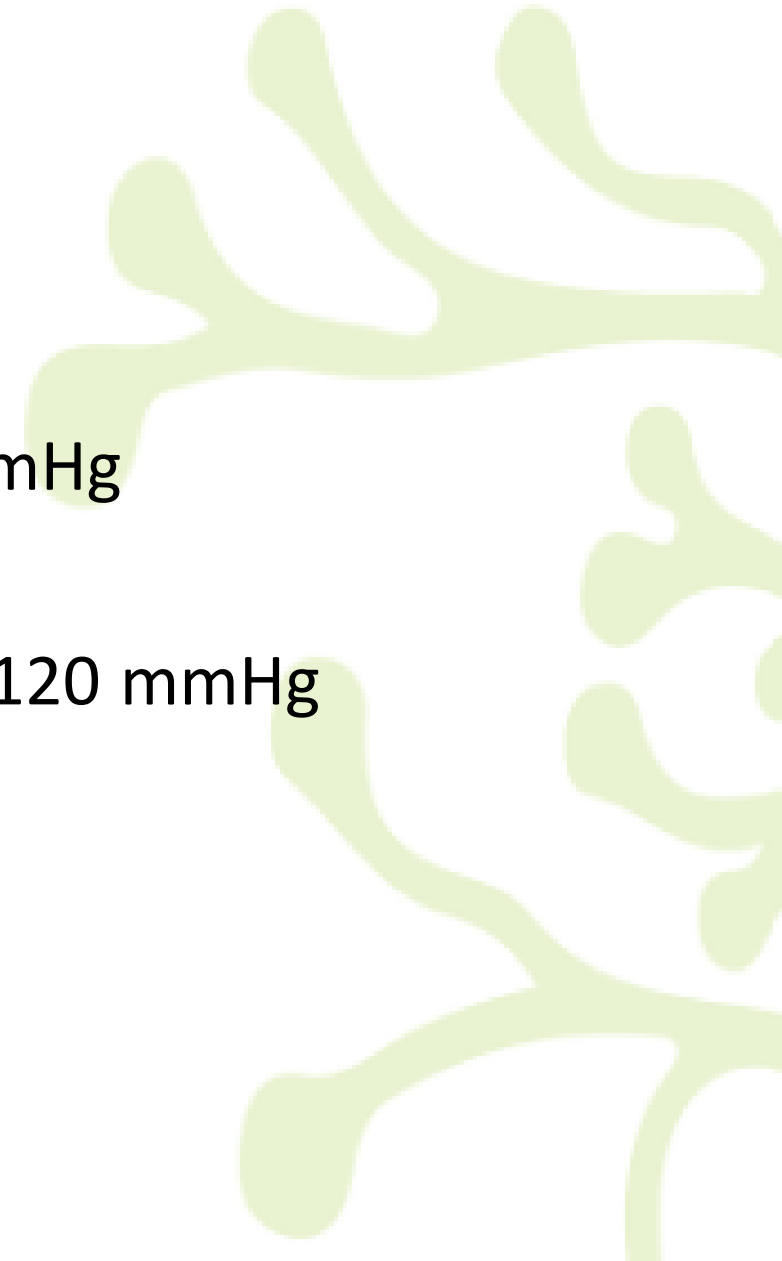
- A. Surdosage en AVK
- B. Anévrisme rompu
- C. Hypertension artérielle chronique
- D. Tumeur cérébrale
- E. Angiopathie amyloïde



Question 3

L'objectif tensionnel à la phase aiguë doit être :

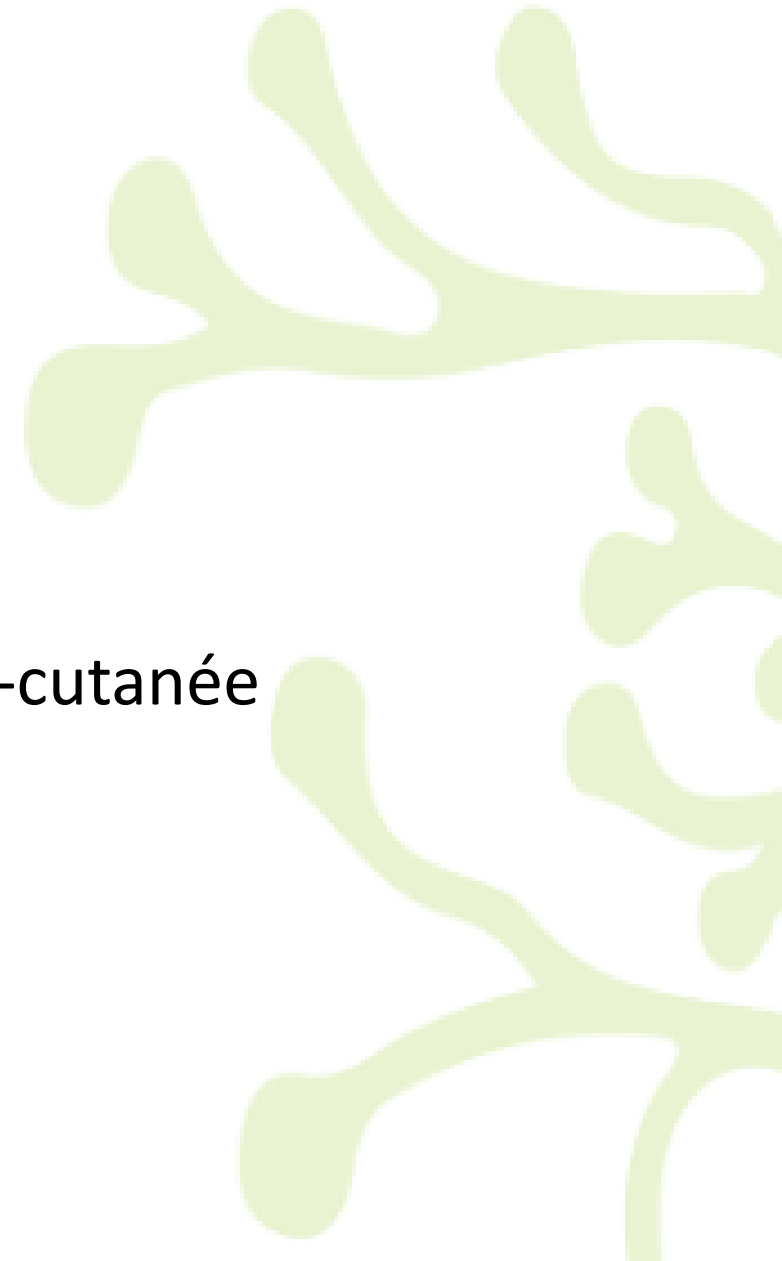
- A. Normalisation rapide < 120/80 mmHg
- B. Abaissement des chiffres tensionnels < 140/90 mmHg
- C. Respect de l'hypertension
- D. Abaissement des chiffres tensionnels si PA > 220/120 mmHg
- E. Aucune intervention sur PA



Question 4

Concernant la prise en charge de l'anticoagulation :

- A. Poursuite des AVK à la même dose
- B. Arrêt des AVK
- C. Administration urgente de PPSB + vitamine K
- D. Relais par héparine hypocoagulante par voie sous-cutanée
- E. Ajustement des doses d'AVK



♥ merci ♥



Email:

moalla_khadijasonda@medecinesfax.org

Compte Facebook: Moalla Khadija

Téléphone: 22778671 /58127421